

INSTRUMEN PENGUKURAN KUALITAS KODE KLINIS PADA SISTEM CASEMIX

Kori Puspita Ningsih
Hartono
Nur Hafidha Hikmayani



INSTRUMEN PENGUKURAN KUALITAS KODE KLINIS PADA SISTEM CASEMIX

Kori Puspita Ningsih, A.Md., S.KM., M.K.M.

Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

INSTRUMEN PENGUKURAN KUALITAS KODE KLINIS PADA SISTEM CASEMIX

Penulis: Kori Puspita Ningsih, A.Md., S.KM., M.K.M.
Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7219-15-2

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, hikmat, dan kesempatan sehingga buku ini, yang berjudul “Instrumen Pengukuran Kualitas Kode Klinis Pada Sistem Casemix”, dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari kepedulian kami terhadap pentingnya kode klinis yang bersumber dari informasi kesehatan pada rekam medis dalam mendukung sistem casemix di Indonesia.

Kualitas kode klinis bukan hanya masalah keakuratan kode, tetapi juga menjadi tantangan koder, dokter dan para pember asuhan untuk lebih peduli dalam menjaga mutu dokumentasi rekam medis sebagai sumber kode diagnosis dan prosedur medis. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi koder untuk memahami konsep kualitas kode klinis pada sistem casemix dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai aspek permasalahan di lapangan seperti penyebab pending klaim, kaidah kodifikasi dari WHO dan regulasi berkaitan dengan koding INA-CBG, hingga pemahaman terhadap kode klinis.. Selain itu, kami berupaya untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami, berbasis bukti, dan aplikatif sehingga dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, pakar kesehatan, dan keluarga yang

memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya mengukur kualitas kode klinis pada sistem casemix,, memperkuat pentingnya dokumentasi kualitas dokumentasi rekam medis, serta meningkatkan mutu manajemen di Rumah Sakit. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca, semoga buku ini menjadi bekal yang berharga dalam menjaga kualitas kode klinis pada sistem casemix.

Februari, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
---------------------	------------

Daftar Isi.....	v
------------------------	----------

Bab 1 Pendahuluan	1
--------------------------------	----------

Bab 2 Sistem Casemix	6
-----------------------------------	----------

A. Pengertian Casemix	6
-----------------------------	---

B. Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)	6
---	---

Bab 3 Kode Klinis.....	13
-------------------------------	-----------

A. Kode Diagnosis (ICD-10).....	13
---------------------------------	----

1. Pengertian ICD-10	13
----------------------------	----

2. Tujuan ICD-10	13
------------------------	----

3. Pemanfaatan ICD-10.....	14
----------------------------	----

4. Struktur dan Isi ICD-10	15
----------------------------------	----

5. Konversi dan Tanda Baca ICD-10.....	17
--	----

6. Kode Ganda Dalam ICD-10.....	21
---------------------------------	----

7. Aturan Koding Morbiditas pada INA-CBG	28
--	----

8. Tata Cara Koding.....	42
--------------------------	----

B. Kode Prosedur Medis (ICD-9CM)	44
--	----

1. Pengertian	44
---------------------	----

2. Struktur dan Isi ICD-9CM.....	45
----------------------------------	----

3. Prinsip Koding Prosedur Medis	45
--	----

4. Jenis Prosedur Medis.....	46
------------------------------	----

5. Tata Cara Koding Prosedur Medis.....	47
---	----

6. Ketentuan Koding Prosedur Medis.....	48
---	----

Bab 4 Permasalahan Kualitas Kode Klinis	55
A. Permasalahan Pending Klaim BPJS Kesehatan	55
1. Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan	55
2. Penatalaksanaan Solusi Penyelesaian Klaim INA- CBG.....	58
B. Permasalahan Kualitas Kode Klinis Pada Sistem Casemix	64
1. Ketidakuratan Pengodean Berdasarkan Prinsip Umum (<i>General Principle</i>).....	64
2. Ketidakakuratan Kode Diagnosis Kombinasi Sesuai Kaidah ICD-10	66
3. Ketidakakuratan Kode Diagnosis Ganda Sesuai Kaidah ICD-10	66
4. Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Sesuai Dokumentasi Penunjang Klinis	73
5. Kegagalan Reseleksi Kode Diagnosis Utama	74
6. Kegagalan Reseleksi Kode Diagnosis Sekunder.....	76
7. Kegagalan Reseleksi Kode Prosedur Medis	78
Bab 5 Instrumen Pengukuran Kualitas Kode Klinis	81
A. Audit Kode Klinis.....	81
B. Instrumen Pengukuran Kualitas Kode Klinis Pada Sistem Casemix.....	85
Bab 6 Penutup	95
Daftar Pustaka	99
Glosarium	104
Profil Penulis.....	107

Bab 1

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program pembangunan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 dan disepakati oleh 193 kepala negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati hal tersebut, oleh karena itu Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target SDGs. Salah satu tujuan SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan program cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC).

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan UHC dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2023 terdapat 2.599 rumah sakit dari total 27.777 fasilitas

pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS (BPJS Kesehatan, 2023).

BPJS kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada rumah sakit dengan metode pembayaran prospektif melalui sistem casemix. Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 2016) bahwa *case based paymet* (casemix) merupakan sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan *software grouper* yang saat ini dikenal dengan *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG). Dasar dari pengelompokkan kode INA-CBG menggunakan sistem klasifikasi yang berlaku secara internasional. Dasar klasifikasi kode diagnosis berdasarkan *International Statistical Classification Of Disease And Related Health Problems, Tenth Revision* (ICD-10) sedangkan dasar klasifikasi prosedur/tindakan medis berdasarkan *The International Classification of Diseases, Clinical Modification* (ICD-9CM) (Presiden RI, 2013).

ICD dikembangkan dan direvisi oleh *World Health Organisation* (WHO). ICD disusun dan dilengkapi berdasarkan hierarki guna mendukung pengelolaan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, dan dapat digunakan juga untuk

membandingkan informasi kesehatan antar rumah sakit, wilayah dan negara. ICD-9CM merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengelompokkan prosedur bedah, diagnostik dan terapeutik, sedangkan ICD-10 merupakan suatu sistem klasifikasi penyakit yang mengelompokkan penyakit-penyakit yang sejenis dengan istilah penyakit dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan (WHO, 2010). ICD-10 paling sering digunakan untuk menyusun kumpulan kode (Delvaux et al., 2020).

Kualitas kode klinis baik kode penyakit berdasarkan ICD-10 dan kode prosedur/tindakan medis berdasarkan ICD-9CM menjadi bagian penting di level manajemen rumah sakit khususnya dalam implementasi sistem casemix. Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kualitas kode diagnosis adalah adanya potensi menurunkan pendapatan rumah sakit hingga 32,6% dan berpotensi menurunkan pendapatan rumah sakit sebesar 4,2% dibandingkan dengan klaim seharusnya (Yuniati, 2017). Penelitian lain di Malaysia juga menunjukkan potensi kerugian yang dialami rumah sakit X ketika coder salah menentukan kode diagnosis mencapai RM 654.303,91 (2,2 miliar rupiah) per tahun (Zafirah, 2018). Kurangnya kualitas kode juga berdampak pada pengembalian klaim pasien BPJS (Ulfa, Octaria and Sari, 2016; Ariyanti and Gifari, 2019; Indawati, 2019) informasi pelaporan yang tidak akurat, resiko kesalahan pengambilan keputusan (Seruni and Sugiansi, 2015), potensi *fraud* dan *abuse* (Ningtyas, Sugiansi and

Wariyanti, 2019) dan masalah ketidakakuratan penghitungan statistik rumah sakit, laporan pelayanan kesehatan tidak berkualitas, kepentingan riset klinik dan pengembangan kebijakan kesehatan oleh pemerintah daerah akan terkendala, serta permasalahan klaim asuransi (Widjaja et al, 2014).

Para peneliti dari berbagai negara juga telah mempelajari kualitas kode klinis. Penelitian pada tahun 1970-an menemukan kesalahan substansial dalam pemberian kode data klinis berkisar antara 20%-80%. Sedangkan penelitian pada 1980-an dilaporkan sedikit meningkat dengan tingkat kesalahan rata-rata sekitar 20%, dan kebanyakan di bawah 50%. Selanjutnya penelitian tahun 1990-an ditemukan dari 1.980 studi, tingkat kesalahan berkisar 0-70% (O'Malley, 2005). Pada beberapa negara seperti di Inggris, akurasi kode data klinis berkisar antara 53-100% (rata-rata 97%), di Arab Saudi tingkat kesalahan pemberian kode data klinis dilaporkan 30%, dan studi lain mengungkapkan tingkat akurasi berkisar 85-95% (Campbell etall, 2001). Hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan bahwa tingkat akurasi kode data klinis telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun demikian angka keakurasian rata-rata masih berkisar antara 30-70% (Dimick, 2010). Hasil *systematic review* menunjukkan median keakuratan kode diagnosis sebesar 80,3% (IQR: 63,3 – 94,1%), sedangkan median keakuratan kode prosedur 84,2% (IQR: 68,7-88,7%). Dari hasil *systematic review* tersebut juga

disampaikan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam tingkat akurasi kode (50,5–97,8%). Penelitian serupa juga dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa ketidaktepatan kode mencapai 25,33% yang disebabkan oleh ketidaklengkapan rekam medis (Windari and Kristijono, 2016). Hal ini juga dipertegas oleh penelitian yang menunjukkan 30% kode diagnosis tidak akurat dan 30% pengisian informasi rekam medis tidak lengkap (Pujiastuti et al, 2014). Dengan demikian dapat disampaikan bahwa secara umum kualitas kode masih diukur berdasarkan keakuratan kode saja. Oleh karena itu diperlukan instrumen pengukuran kualitas kode klinis, khususnya untuk mendukung implementasi sistem casemix di Indonesia.

Bab 2

Sistem Casemix

A. Pengertian Casemix

Case based paymet (casemix) merupakan sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan software grouper yang saat ini dikenal dengan *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG). BPJS kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada rumah sakit dengan metode pembayaran prospektif melalui sistem casemix. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 2016).

B. Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)

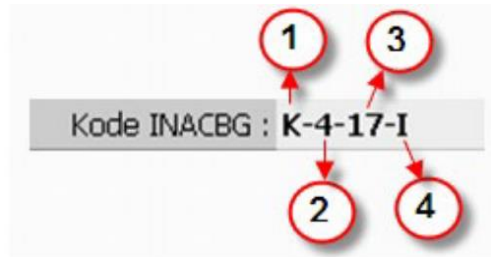
1. Penyelenggaraan INA-CBG

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG), INA-CBG adalah tarif paket pelayanan kesehatan

yang mencakupi seluruh komponen biaya rumah sakit, mulai dari pelayanan non medis sampai tindakan medis. Dalam sistem ini, pasien akan dikelompokkan dalam satu episode yang dihubungkan dengan biaya pelayanan. Tiap kelompok memiliki ciri klinis yang sama, sehingga pemakaian sumber daya serta biaya yang dikeluarkan juga akan sama. Pengelompokkan ini didasari pada data biaya dan data coding penyakit dari rumah sakit terpilih.

INA-CBG memiliki sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen yang berhubungan secara langsung dengan output layanan adalah clinical pathway, coding penyakit dan teknologi informasi, terdapat juga komponen yang tidak secara langsung mempengaruhi proses penyusunan tarif INA-CBG untuk setiap kelompok kasus yaitu komponen *costing*. Dasar pengelompokkan, INA-CBG menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan prosedur medis yang menjadi bukti tata laksana pelayanan dan terdokumentasi pada rekam medis. Klasifikasi kode diagnosis menggunakan ICD-10 dan untuk kode prosedur medis menggunakan ICD-9CM. Pengelompokkan menggunakan sistem teknologi informasi merupakan Aplikasi INA-CBG sehingga dihasilkannya 1.075 Group Kelompok Kasus yang

terdiri dari 786 kelompok kasus rawat inap dan 289 kelompok kasus rawat jalan. Setiap group memiliki lambang dengan kode kombinasi alfabet dan angka (Kemenkes RI, 2021).



Gambar 2.1 Struktur Kode INA-CBG

Keterangan:

- Digit ke-1 (alfabetik): menggambarkan kode *Casemix Main Groups* (CMG). Kode CMG adalah klasifikasi tahap pertama yang dilabelkan dengan huruf Alphabet (A sampai Z) yang disesuaikan dengan ICD-10 Versi Tahun 2010 untuk setiap sistem organ tubuh manusia. Terdapat 29 CMG dalam INA-CBG
- Digit ke-2 (numerik): menggambarkan tipe kelompok kasus (*Case Groups*). Kelompok kasus adalah sub-group kedua yang menunjukkan spesifikasi atau tipe kelompok kasus, yang dilabelkan dengan angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan).
- Digit ke-3 (numerik): menggambarkan spesifikasi kelompok kasus, yaitu sub-group ketiga yang menunjukkan spesifik CBG yang dilambangkan dengan numerik mulai dari 01 sampai dengan 99.

- d. Digit ke-4 (romawi): menggambarkan tingkat keparahan (*severity level*) kelompok kasus. *Severity level* adalah sub-group keempat yang menggambarkan tingkat keparahan kasus yang dipengaruhi adanya komorbiditas ataupun komplikasi dalam masa perawatan. Keparahannya dalam INA-CBG terbagi menjadi:
- 1) "0" - untuk rawat jalan;
 - 2) "I"-Ringan" untuk rawat inap dengan tingkat keparahan 1 (tanpa komplikasi maupun komorbiditi);
 - 3) "II"-Sedang" untuk rawat inap dengan tingkat keparahan 2 (dengan mild komplikasi dan komorbiditi);
 - 4) "III"-Berat" untuk rawat inap dengan tingkat keparahan 3 (dengan major komplikasi dan komorbiditi).

2. Pembayaran Tambahan (Top Up)

Terdapat pembayaran tambahan (*Top Up*) dalam sistem INA-CBG untuk kasus-kasus tertentu yang masuk dalam Special CMG, yang dikelompokkan menjadi:

- a. *Special CMG* untuk *special procedures*, *special drugs*, *special investigations*, dan *special prosthesis* yaitu:
 - 1) *Special procedures* merupakan tambahan pembayaran untuk prosedur tertentu baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - 2) *Special drugs* adalah tambahan pembayaran untuk obat tertentu baik rawat jalan maupun rawat inap.

- 3) *Special investigations* merupakan tambahan pembayaran untuk pemeriksaan penunjang tertentu di rawat jalan
- 4) *Special prosthesis* merupakan tambahan pembayaran untuk prostesis tertentu di rawat inap.
- b. *Special CMG untuk Subacute Cases dan Chronic Cases*
Special CMG untuk subacute cases dan chronic cases adalah untuk kasus-kasus psikiatri dan kusta dengan ketentuan lama hari rawat (LOS) di FKRTL sebagai berikut:
 - 1) fase akut: 1 sampai dengan 42 hari
 - 2) fase subakut: 43 sampai dengan 103 hari
 - 3) fase kronis: 104 sampai dengan 180 hari

Dalam hal pasien mendapatkan perawatan lebih dari 180 hari, maka diklaimkan satu episode dengan fase kronis. *Special CMG* untuk *subacute cases* dan *chronic cases* berlaku di semua FKRTL yang memiliki pelayanan psikiatri dan kusta serta memenuhi kriteria lama hari rawat sesuai ketentuan di atas.

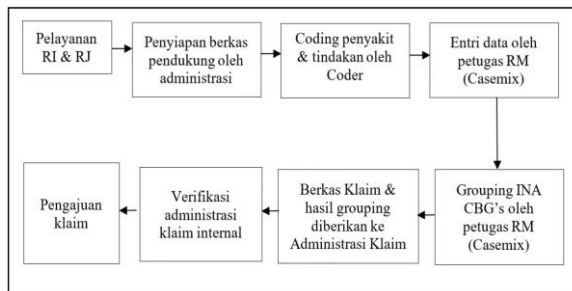
3. Alur Klaim

Adapun alur pengajuan klaim fasilitas layanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan sesuai dengan Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Tahun 2015 yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Biaya pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dibayar dengan paket INA-CBG tanpa pengenaan iuran biaya kepada peserta.

- b. Tarif paket INA-CBG sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Permenkes No 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- c. Tarif paket INA-CBG sudah mencakup biaya seluruh pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, baik biaya administrasi, jasa pelayanan, sarana, alat/bahan habis pakai, obat, akomodasi dan lain-lain
- d. Klaim diajukan secara kolektif oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dalam bentuk *softcopy* (luaran aplikasi INA-CBG Kementerian Kesehatan yang berlaku) dan *hardcopy* (berkas pendukung klaim).
- e. Tagihan klaim di fasilitas kesehatan lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan lanjutan dan Petugas Verifikator BPJS Kesehatan.
- f. Klaim diajukan kepada kantor cabang atau kantor operasional kabupaten/kota BPJS Kesehatan secara kolektif setiap bulan dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan lain sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi pelayanan
 - 2) Berkas pendukung dari masing – masing pasien yang terdiri:
 - a) Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

- b) Surat perintah rawat inap
- c) Resume medis lengkap yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP)
- d) Bukti pelayanan lain yang ditandatangani oleh DPJP (bila perlu), seperti:
 - (1) Laporan operasi.
 - (2) Protokol terapi dan regimen (jadwal pemberian obat) pemberian obat khusus.
 - (3) Perincian tagihan rumah sakit secara (manual atau *automatic billing*).
 - (4) Berkas pendukung lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.



Gambar 2.2 Alur Pengajuan Klaim INA-CBG

Sumber: Panduan Administrasi Klaim BPJS tahun 2015,
PMK No. 26 tahun 2021

Bab 3

Kode Klinis

A. Kode Diagnosis (ICD-10)

1. Pengertian ICD-10

ICD-10 merupakan singkatan dari *The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10th Revision*. ICD-10 menyeragamkan definisi penyakit dan masalah terkait kesehatan. ICD-10 dipromosikan WHO sebagai suatu klasifikasi yang dapat untuk merekam pengalaman-pengalaman dari berbagai negara dalam satu aturan yang sama sehingga informasi morbiditas dan mortalitas yang dihasilkan berdasarkan sistem pengkodean ICD-10 bisa dikomparasi (WHO, 2010).

2. Tujuan ICD-10

ICD-10 dapat digunakan untuk memproses dan merekam data penyakit dan masalah terkait kesehatan yang menyebabkan seorang berhubungan, mencari atau memperoleh pelayanan kesehatan, di samping untuk kepentingan memproses data mortalitas (WHO, 2010).

3. Pemanfaatan ICD-10

Profesional Rekam Medis di lingkungan RS menggunakan data tentang penyakit dan operasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian medis. Untuk alasan ini, diperlukan sistem klasifikasi yang sangat rinci. Jika terlalu banyak penyakit dikelompokkan dalam satu nomor kode, proses alokasi dokumen yang ingin diteliti akan menjadi lebih sulit. Sebaliknya, perencanaan kebijakan kesehatan, seperti kementerian kesehatan dan *World Health Organization* (WHO), menggunakan data klasifikasi penyakit untuk statistik, epidemiologi, dan demografi. Karena terlalu banyak kasus untuk dianalisis secara statistik, penggolongan yang terlalu rinci tidak diperlukan untuk keperluan ini.

International Classification of Disease (ICD) bertujuan untuk menyatukan dua kepentingan di atas dengan mengklasifikasikan penyakit, cedera, dan sebab kematian untuk tujuan statistik. WHO mendorong klasifikasi ini agar negara-negara di seluruh dunia dapat merekam data kesehatan dengan cara yang sama. Sejak dibuat pertama kali pada tahun 1900-an, ICD-10 telah mengalami banyak perubahan. Untuk memenuhi kebutuhan epidemiologi umum dan berbagai manajemen kesehatan. Kode ICD telah berkembang dari sekedar mengelompokkan informasi morbiditas dan mortalitas untuk tujuan statistik hingga digunakan untuk berbagai tujuan, seperti administrasi, *reimbursement*,

dan riset di fasilitas kesehatan. Dalam tujuan *reimbursement*, pemanfaatan kode ICD menjadi komponen kunci dalam penentuan biaya pada implementasi sistem casemix di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kode ICD akan menentukan hasil kode CMG yang menunjukkan besar biaya klaim.

4. Struktur dan Isi ICD-10

Menurut (WHO, 2010) ICD-10 terdiri dari 3 volume yaitu:

a. Volume 1. Tabular List

Pada volume 1 menjelaskan klasifikasi utama terdiri daftar 3 karakter dan daftar tabel inklusi dan sub kategori 4 karakter. Kategori 3 karakter digunakan untuk pelaporan ke WHO terkait mortality database dan perbandingan umum internasional. Selain itu juga terdapat daftar morfologi neoplasma untuk kode tambahan kode neoplasma.

b. Volume 2. Instruksi Manual

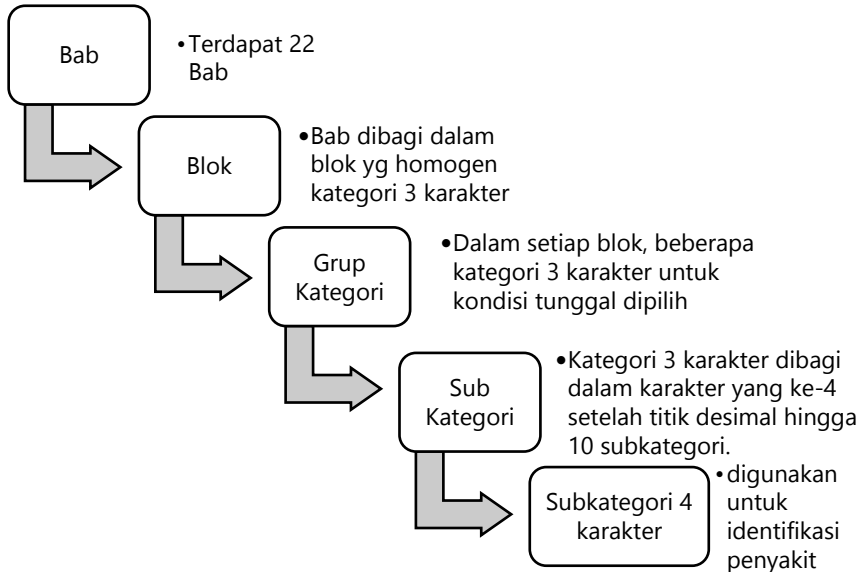
Pada volume 2 menjelaskan petunjuk pemakaian yang meliputi introduction, deskripsi tentang ICD-10, cara menggunakan ICD-10, aturan kode morbiditas dan mortalitas, penyajian statistik, sejarah perkembangan ICD-10, referensi dan indeks.

c. Volume 3. Alphabetical Index

Pada volume 3 terdiri dari 3 bagian yaitu seksi I yaitu Alphabetical index to diseases and nature of injury, seksi II yaitu *External causes of injury* dan Seksi III yaitu

Table of drugs and chemicals, serta koreksi kode (Corrigenda to volume 1).

Berikut struktur kode ICD-10 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Kode ICD-10

Sumber: WHO, 2010

Hasil narative review pembaharuan ICD-10 menjadi ICD-11 juga telah dilakukan yang menunjukkan bahwa terdapat penambahan 6 bab, dari 22 Bab pada ICD-10 menjadi 26 Bab pada ICD-11 (Krawczyk and Swiecicki, 2020).

5. Konversi dan Tanda Baca ICD-10

a. *Inclusion Terms*

Diantara kategori tiga-karakter dan empat-karakter pada kode ICD-10, umumnya juga terdapat daftar sejumlah terminologi diagnostik. Hal tersebut dikenal sebagai terminologi inklusi, atau *inclusion terms*. Terminologi ini diberikan, semacam tambahan dari judul, sebagai contoh dari pernyataan-pernyataan diagnostik yang terklasifikasi dalam rubrik tersebut. Bisa berupa kondisi yang berbeda, atau sinonimnya, tetapi bukan merupakan subklasifikasi dari rubrik tersebut. *Inclusion terms* ditulis sebagai pedoman isi rubrik. Sebagian besar isinya berkaitan dengan istilah-istilah penting dan umum digunakan dalam rubrik. Lainnya adalah letak atau kondisi perbatasan (*borderline*) yang membedakan antara satu subkategori dengan yang lain. Daftar inclusion terms biasanya bersifat *exhaustive*, dan nama-nama alternatif tentang diagnosis tercantum dalam volume 3 yang harus dirujuk terlebih dahulu.

b. *Exclusion Terms*

Rubrik-rubrik tertentu berisikan daftar kondisi-kondisi yang diawali dengan kata "*Excludes*" (tidak termasuk/pengecualian). Istilah ini adalah untuk kondisi-kondisi yang, bila menilik judulnya, diperkirakan terklasifikasi di rubrik tersebut, ternyata diklasifikasi di bagian lain. Di belakang istilah-istilah yang *excluded* tersebut adalah kode-kode dari

kategori atau subkategori, dalam tanda kurung (). Pengecualian yang umum bagi serangkaian kategori atau untuk semua sub-kategori dari satu kelompok 3-karakter dapat ditemukan pada catatan yang berjudul "Excludes" yang mengikuti Bab, Blok atau judul kategori.

c. *Glossary Descriptions*

Sebagai tambahan dari '*inclusion*' dan '*exclusion terms*', Bab V tentang Kelainan Mental dan Perilaku menggunakan '*glossary descriptions*' (daftar istilah atau deskripsi) untuk menerangkan isi rubrik. Hal ini disebabkan karena terminologi untuk kelainan mental sangat bervariasi, khususnya antar negara yang berbeda. Dan nama yang sama dapat digunakan untuk deskripsi kondisi yang berbeda.

d. *Parentheses* ()

Tanda baca kurung berbentuk *parentheses* () digunakan pada 4 (empat) situasi sebagai berikut:

- 1) Digunakan untuk mengurung kata-kata tambahan yang mungkin mengikuti suatu istilah diagnostik tanpa mempengaruhi nomor kode dari kata-kata yang diluar tanda kurung.
- 2) Untuk mengurung kode dari '*exclusion terms*'
- 3) Pada judul blok kategori, untuk mengurung kode 3-karakter yang termasuk kategori blok tersebut.
- 4) Untuk mengurung kode sangkur dalam kategori asterisk atau kode asterisk yang mengikuti istilah dari kode sangkur.

e. *Square Bracketts []*

Tanda baca *Square Bracketts []* digunakan pada situasi:

- 1) Untuk mengurung sinonim, kata-kata alternatif/pengganti, atau frasa-frasa penjelasan.
- 2) Untuk merujuk pada catatan sebelumnya
- 3) Untuk mengacu pada subkategori 4-karakter yang telah dinyatakan sebelumnya, yang biasa digunakan untuk sejumlah kategori.

f. *Colon:*

Tanda colon: digunakan dalam daftar *inclusion* atau *exclusion terms* bilamana suatu kata yang mendahuluinya belum lengkap pada rubrik tersebut. Kata tersebut memerlukan satu/lebih kata sifat (*modifying / qualifying*) yang menerangkan sesuatu sebelum ditentukan nomor kode yang sesuai.

g. *Brace.* }

Digunakan dalam daftar *inclusion* dan *exclusion terms* untuk menunjukkan bahwa baik kata-kata yang mendahului maupun sesudahnya bukanlah kata yang lengkap. Kata-kata yang mendahuluinya harus dijelaskan dengan satu/lebih kata-kata sesudahnya.

h. *NOS*

Merupakan singkatan dari "*Not Otherwise Specified*" yang berarti '*unspecified*' atau '*unqualified*'. Petugas coding (koder) harus berhati-hati, jangan menetapkan suatu terminologi ke dalam kategori '*unqualified*' sebelum merasa yakin benar bahwa tidak ada keterangan yang dapat membantu menggolongkan ke

dalam kategori yang lebih spesifik.

i. **NEC**

Kata-kata "*Not Elsewhere Classified*" yang digunakan dalam 3-karakter kategori berfungsi sebagai 'peringatan' bahwa varian spesifik tertentu dari kondisi tersebut berada di bagian lain dari klasifikasi. Sehingga, bila perlu, terminologi yang lebih tepat harus dicari dulu dalam indeks.

j. **And**

Bisa berarti "*and*" atau "*or*". Akan tetapi berbeda dengan istilah "*with*". Yang bermakna "dengan". Maka jika terdapat kata *with* berarti kategori tersebut hanya dapat digunakan jika kedua kondisi tersebut didapatkan secara bersamaan.

k. **Point Dash .-**

Pada beberapa kasus, karakter ke-4 digantikan oleh tanda 'dash' atau strip (-). Umumnya kode seperti ini muncul dalam Indeks Alfabetik di Volume 3. Kode ini menunjukkan bahwa ada karakter ke-4 yang harus dicari pada kategori yang sesuai, sehingga koder harus merujuk pada volume 1 untuk menemukan rincian kategori yang sesuai dengan diagnosis yang akan di kode agar kode yang dihasilkan lebih spesifik.

l. **Cross-references**

Tanda baca ini hanya dijumpai pada indeks alfabetik di volume 3. *Cross-references* digunakan untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dari terminologi dalam indeks. Kata-kata "*see*" mengharuskan koder

untuk merujuk pada terminologi lain yang ditunjukkan tadi; "*see also*" mengarahkan koder untuk merujuk ke bagian lain dalam indeks bilamana pernyataan yang di-kode juga berisikan informasi yang terdapat dalam kondisi di bagian lain yang harus dirujuk tadi.

6. Kode Ganda Dalam ICD-10

Dalam ICD dikenal kode khusus yang terdiri dari (WHO, 2010):

a. Kode Kombinasi

Kode tunggal yang digunakan untuk mengklasifikasi dua diagnosis, atau satu diagnosis utama dengan prosedur sekunder (manifestasi) atau dengan komplikasi terkait. Kode kombinasi dapat diketahui dari subterm yang muncul dalam indeks alfabetik dan dengan melihat pada *inclusion* ataupun *exclusion*.

Contoh:

I11 Hypertensive heart disease <i>Includes:</i> any condition in I50.-, I51.4-I51.9 due to hypertension I11.0 Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure Hypertensive heart failure I11.9 Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure Hypertensive heart disease NOS	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10 - with - - heart involvement (conditions in I51.4-I51.9 due to hypertension) (see also Hypertension, heart) I11.9 - - kidney involvement (see also Hypertension, kidney) I12.9 - - renal sclerosis (conditions in N26.-) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - - - with - - - failure (conditions in N18.-, N19.-) I12.0
I12 Hypertensive renal disease <i>Includes:</i> any condition in N03-N07, N18.-, N19 or N26 due to hypertension arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis <i>Excludes:</i> secondary hypertension (I15.-) I12.0 Hypertensive renal disease with renal failure Hypertensive renal failure I12.9 Hypertensive renal disease without renal failure Hypertensive renal disease NOS	

Gambar 3.2 Kategori Hipertensi

Sumber: Buku ICD-10, Volume 1 & 3, Hypertension

b. Kode ganda *Dagger* dan *Asterisk*

Kode ganda digunakan untuk beberapa kondisi yang tidak dapat dialokasikan dengan kode kombinasi. Penggunaan kode ganda dapat diketahui dari indeks Alfabetik maupun daftar tabulasi dimana tanda *Dagger* dilambangkan dengan belati (†) dan tanda *Asterisk* dilambangkan dengan bintang (*).

Untuk keperluan presentasi statistik, dalam prinsip ICD, kode *dagger* merupakan kode primer dan harus selalu digunakan, sedangkan kode bintang (asterisk) digunakan sebagai kode tambahan yang bersifat opsional. Dalam koding, kode asterisk tidak boleh digunakan secara tunggal. Namun demikian, untuk keperluan koding morbiditas, urutan (*sequence*) antara dagger dan asterisk dapat dibalik bilamana fokus utama pelayanan adalah manifestasi klinisnya. Adapun statistik yang menggunakan kode dagger sesuai klasifikasi tradisional umumnya untuk mempresentasikan data mortalitas dan aspek lain dari layanan kesehatan.

Petunjuk penggunaan kode ganda ini dapat diketahui dari indeks alfabetik maupun daftar tabulasi. Terdapat tiga format berbeda dari rubrik yang mengandung kode dagger di dalamnya, yaitu:

1) Tanda † dan * muncul pada judul rubrik

Maka semua kriteria dalam rubrik tersebut merupakan klasifikasi rangkap / ganda dan semua memiliki kode alternatif yang sama.

Contoh:

A17.0† *Tuberculous meningitis* (G01*) *Tuberculosis of meninges (cerebral, spinal)*
Tuberculous leptomeningitis

2) Tanda † muncul pada judul rubrik, tetapi * tidak

Maka semua kriteria / terminologi dalam rubrik tersebut merupakan klasifikasi rangkap, namun memiliki kode asterisk (*) yang berbeda.

Contoh:

A18.1† *Tuberculosis of genitourinary system*

Tuberculosis of:

Bladder (N33.0*)

Cervix (N74.0*)

Kidney (N29.1)

Male genital organs (N51.- *)

Ureter (N29.1*)

Tuberculous female pelvic inflammatory disease
(N74.1*)

3) Tanda † maupun * tidak muncul dalam judul rubrik.

Maka rubrik tersebut (dan isinya) bukanlah klasifikasi rangkap, namun ada beberapa terminologi individual yang tergolong rangkap. Biasanya terminologi tersebut akan ditandai dengan tanda gambar berikut kode alternatifnya.

Contoh:

A54.8 *Other gonococcal infections*

Gonococcal:

.....

Peritonitis † (K67.1*)

Pneumonia † (J17.0*)

Septicemia

Skin lesions

c. Kode Ganda Lainnya

Ada beberapa situasi, selain yang dijelaskan dalam sistem *dagger* & *asterisk* tadi, yang membolehkan penggunaan dua kode untuk mendeskripsikan kondisi seseorang secara utuh. Catatan dalam daftar tabulasi yang berbunyi, "*Use additional code, if desired*" menunjukkan situasi ini. Kode tambahan ini hanya digunakan dalam tabulasi khusus.

Kode ganda tersebut antara lain adalah:

1) Agen Penyebab Infeksi

Untuk infeksi lokal, yang terklasifikasi dalam bab "*body systems*", kode dari Bab I dapat ditambahkan guna identifikasi organisme penyebab infeksi, bilamana informasi ini tidak muncul dalam judul rubrik. Sebuah blok kategori, B95 – B97, disediakan dalam Bab I untuk tujuan ini.

2) Neoplasma dengan aktivitas fungsional

Bagi beberapa neoplasma dalam Bab II dapat ditambahkan kode yang sesuai dari Bab IV untuk

menunjukkan jenis aktivitas fungsional dari neoplasma. Menurut ICD-10 (WHO, 2010) dan pedoman INA CBG (Kemenkes RI, 2021) bahwa dalam menentukan kode neoplasma :

- a) Coder memastikan kesesuaian hasil pathology anatomi dengan diagnosis dari DPJP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka coder melakukan konfirmasi kepada DPJP dengan menunjukkan dokumentasi rekam medis dan hasil pathology anatomi.
- b) Coder menentukan kode morfologi untuk mengetahui *behaviour* (sifat perilaku) dari neoplasma pada Volume III ICD-10. Cek deskripsi kode morfologi pada bagian *Morphology Of Neoplasma* Volume I ICD-10. contoh: M8000/0 yang bermakna Neoplasma benign

In the nomenclature given here, the morphology code numbers include the behaviour code appropriate to the histological type of neoplasm; this behaviour code should be changed if the other reported information makes this appropriate. For example, chordoma is assumed to be malignant and is therefore assigned the code number M9370/3; the term 'benign chordoma' should, however, be coded M9370/0. Similarly, superficial spreading adenocarcinoma (M8143/3) should be coded M8143/2 when described as 'noninvasive', and melanoma (M8720/3), when described as 'secondary', should be coded M8720/6.

The following table shows the correspondence between the behaviour code and the different sections of Chapter II:

Behaviour code		Chapter II categories
/0	Benign neoplasms	D10–D36
/1	Neoplasms of uncertain and unknown behaviour	D37–D48
/2	In situ neoplasms	D00–D09
/3	Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary	C00–C76, C80–C97
/6	Malignant neoplasms, stated or presumed to be secondary	C77–C79

³ Except cystadenomas of ovary in M844–M849, which are considered to be malignant.

Gambar 3.3 *Morphology Of Neoplasma*

Sumber: Volume I ICD-10

- c) Setelah diketahui sifatnya (*behaviour*), cari kode topografi (lokasi) neoplasma pada *Table Of Neoplasma* Volume III ICD-10, pilih kolom sesuai dengan sifatnya (*behaviour*).

	Malignant				Uncertain or unknown behavior
	Primary	Secondary	In situ	Benign	
- abdomen, abdominal.....	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- cavity.....	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- organ.....	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- viscera.....	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- wall.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- abdominopelvic.....	C76.8	C79.8		D36.7	D48.7
- accessory sinus - see Neoplasm, sinus					
- acromion (process) ✦.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- adenoid (tissue).....	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- adipose tissue - see Neoplasm, connective tissue					
- adnexa (uterine).....	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- adrenal (gland).....	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- cortex.....	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- medulla.....	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- ala nasi (external).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- alimentary canal or tract NEC.....	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9

Gambar 3.4 Table Of Neoplasma

Sumber: Volume III ICD-10

Misal Tumor jinak pada dinding perut, maka setelah coder menentukan kode morfologi M8000/0 selanjutnya akan mencari lokasi abdomen wall dengan memilih kolom *Benign* (D36.7).

- d) Coder memastikan kesesuaian kode morfologi dan kode topologi sesuai aturan pada bagian *Morphology of Neoplasma* Volume I ICD-10, bahwa kode sifat neoplasma berpasangan dengan kode lokasi neoplasma. Misal Tumor jinak pada dinding perut, maka kode morfologi *benign* (0) hanya bisa berpasangan dengan kode D10-D36 (gambar 3.3).

- e) Coder menentukan hasil akhir kode neoplasma dengan ketentuan kode topografi sebagai kode utama, dan morfologi sebagai kode tambahan. Contoh hasil akhir dari kode Tumor jinak pada dinding perut adalah D36.7, M8000/0.
- 3) Penyebab Gangguan Mental Organik
Untuk kondisi-kondisi yang terklasifikasi dalam F00 – F09 (*Organic, including symptomatic, mental disorders*) dalam Bab V, suatu kode dari Bab lain dapat ditambahkan untuk menunjukkan penyebabnya, misalnya penyakit yang mendasari, cedera atau gangguan lain pada otak.
- 4) Agen toksik
Bilamana suatu kondisi disebabkan oleh agen toksik, suatu kode dari Bab XX dapat ditambahkan untuk identifikasi agen tersebut.
- 5) Kode Sebab Luar
Bilamana dua kode dapat digunakan untuk menggambarkan suatu cedera, keracunan atau efek samping lain: suatu kode dari Bab XIX, yang mendeskripsikan kondisi cedera, ditambah kode dari Bab XX, yang menunjukkan penyebabnya. Kode mana yang dipilih sebagai kode tambahan tentunya tergantung pada tujuan pengumpulan datanya. (baca introduction Bab XX pada Volume 1).

7. Aturan Koding Morbiditas pada INA-CBG

Aturan Koding Morbiditas pada INA-CBG mengacu pada ICD-10 Versi Tahun 2010 (Kemenkes, 2021):

- a. **Dalam hal koder tidak berhasil melakukan klarifikasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), maka koder menggunakan aturan *Rule Morbidity* (Rule MB1 sampai MB5) untuk memilih kembali kode diagnosis utama (reseleksi)**

Pengodean morbiditas bergantung pada kelengkapan ringkasan pulang berikut rincian diagnosis pasien, serta prosedur tindakan selama episode asuhan rawatnya di rumah sakit atau institusi asuhan kesehatan. Dimana dalam satu episode perawatan seorang pasien mungkin saja dirawat karena berbagai diagnosis. Pada kondisi tersebut, *clinical coder* harus mampu reseleksi diagnosis utama.

Pemilihan kondisi/diagnosis utama diatur pada Rule Morbiditas pada ICD-10. Penerapan Rules Morbiditas akan memudahkan pengkode menyeleksi diagnosis utama pasien. Berikut aturan *morbidity rule* (WHO, 2010):

1) Rule MB1: Kondisi Minor Dilaporkan Sebagai Kondisi Utama

Manakala suatu kondisi minor, sudah lama atau secara mendadak muncul dan dilaporkan sebagai Kondisi Utama, dan di samping itu ada kondisi yang lebih signifikan relevansinya bagi terapi yang telah diberikan ditulis sebagai Kondisi Sekunder, maka

lakukan Reseleksi Kondisi yang lebih signifikan sebagai kondisi utama.

Contoh :

Kondisi utama : *Gastritis*

Kondisi lain. : *Carcinoma* usus besar

Prosedur : *Colectomy*

LOS 5 minggu

Hasil reselection :

Kondisi Utama : *Carcinoma colon*

2) Rule MB2: Beberapa Kondisi direkam Sebagai Kondisi Utama

Apabila tidak bisa menggunakan kode kombinasi untuk mengkode kondisi-kondisi yang digabung menjadi satu sebutan diagnosis, dan di rekam medis ada informasi yang lebih mengarah ke satu dari kondisi-kondisi yang ditulis sebagai kondisi utama (*main diagnosis*), pilih kondisi ini. Bila tidak ada, pilih yang pertama disebut.

Contoh:

Kondisi utama : *Osteoporosis*

Candida bronchopneumonia

Rheumatism

Kondisi lain : -

Bidang spesialisasi : Penyakit Paru

Hasil reselection :

Kondisi Utama : *Osteoporosis Candida
bronchopneumonia*

3) Rule MB3: Simtoma ditulis sebagai Kondisi Utama

Manakala istilah simtom atau tanda-tanda direkam sebagai diagnosis utama, dan ada kondisi lain yang jelas terdiagnosis, maka pilih kembali (*reselect*): Kondisi lain yang terdiagnosis itu sebagai diagnosis utama. Simtoma atau tanda-tanda (gejala) akan berkode R (Bab XVIII).

Contoh:

Kondisi utama : *Hematemesis*

Kondisi lain : *Varices esophagus*

Cirrhosis hepatis

Spesialis : Penyakit Dalam konsul ke Bedah

Hasil reseleksi :

Kondisi utama : *Varices esophagus pada cirrhosis hepatis* (K74.-! I98.2*)

4) Rule MB4 : *Specificity* (Kekhususan)

Manakala ada informasi yang lebih tepat terdokumentasi di rekam medis pasien, terkait diagnosis utama yang telah dirinci dalam istilah umum, gunakan informasi yang paling spesifik untuk memilih yang paling tepat.

Contoh:

Kondisi utama : CVA

Kondisi lain. : *Stroke*

Hemiplegia

Cerebral haemorrhage

Hasil reseleksi :

Kondisi utama : *Stroke cerebral hemorrhage*

5) Rule MB5 : Diagnoses Utama Alternatif

Manakala istilah simtom atau tanda-tanda yang direkam sebagai diagnosis utama dengan indikasi bahwa ditimbulkan akibat satu atau lain kondisi yang disandang pasiennya, maka pilih simtom sebagai kondisi utama. Apabila ada 2 (dua) kondisi maka pilih yang pertama disebut.

Contoh:

Kondisi utama : Sakit kepala mungkin karena sinusitis atau stres.

Hasil reseleksi:

Kondisi utama : Sakit kepala

b. Aturan Koding Spesifik

Aturan koding diagnosis secara spesifik pada implementasi sistem csemix sesuai dengan Pedoman INA-CBG. Berikut beberapa aturan koding spesifik (Kemenkes, 2021) :

1) Pengodean kondisi dugaan (suspek), gejala, penemuan abnormal, dan situasi tanpa penyakit.

Jika klinis dan/atau pemeriksaan penunjang.

Contoh diagnosis suspek:

Ditemukan massa/benjolan di payudara kiri berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang prominen maka diagnosis utama adalah suspek neoplasma di

payudara kiri sehingga dikode Z03.1 (*Observation For Suspected Malignant Neoplasm*). Untuk kasus neoplasma dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi (PA) dinyatakan sebagai *neoplasm of uncertain or unknown behaviour* maka menggunakan kode diagnosis D37-D48 tergantung lokasinya.

2) Pengodean kondisi multipel.

Diagnosis untuk kondisi multipel seperti cedera multipel, gejala sisa (sekuele) multipel dari penyakit atau cedera sebelumnya, atau kondisi multipel yang terjadi pada penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), yaitu:

- a) jika salah satu kondisi yang jelas lebih berat dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan dengan yang lain, maka dicatat sebagai diagnosis utama dan yang lainnya sebagai diagnosis sekunder.
- b) jika tidak ada satu kondisi yang lebih dominan, maka diagnosis seperti fraktur multipel, cedera kepala multiple, atau penyakit HIV yang menyebabkan infeksi multipel merupakan diagnosis utama, dan kondisi spesifik sebagai diagnosis sekunder.

Contoh:

Diagnosis Utama : *Multiple open fracture of femur*

Diagnosis Sekunder : *Open fracture of shaft of femur*
Open fracture of lower of end of femur

Maka kode yang tepat adalah S72.71 (*multiple open fracture of femur*) sebagai diagnosis utama, S72.31 (*open fracture of shaft of femur*) dan open S72.41 (*fracture of lower of end of femur*) sebagai diagnosis sekunder.

3) Pengodean kategori kombinasi.

ICD-10 menyediakan kategori tertentu dimana dua diagnosis yang berhubungan diwakili oleh satu kode. Pengodean kategori kombinasi sudah dijelaskan pada Bab 3 Sub bab 6.

4) Pengodean sekuele kondisi tertentu

Kode ICD-10 Versi Tahun 2010 untuk sekuele ("*sequelae of...*") yaitu B90-B94, E64.-, E68, G09, I69., O97, T90-T98, dan Y85-Y89. Kode sekuele digunakan untuk menunjukkan kondisi yang tidak didapatkan lagi. Aturan koding untuk sekuele yaitu:

- a) jika terdapat kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, sebagai penyebab masalah yang saat ini sedang diperiksa atau diobati, maka kondisi tersebut menjadi diagnosis utama dan kode "*sequelae of ...*" ditambahkan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh :

Diagnosis Utama: *Dysphasia* akibat infark otak lama

Diagnosis Sekunder: -

Maka kode yang tepat: R47.0 (*Dysphasia and Aphasia*) sebagai diagnosis utama dan I69.3

(*Sequelae of Cerebral Infarction*) sebagai diagnosis sekunder.

- b) jika tidak ada kondisi yang lebih spesifik daripada sekuele, maka sekuele menjadi diagnosis utama.

Contoh:

Diagnosis Utama: Efek lanjut poliomiелitis

Diagnosis Sekunder: -

Maka kode yang tepat: B91 (*Sequelae of poliomyelitis*) sebagai diagnosis utama karena informasi lain tidak tersedia.

5) Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis.

Pengodean kondisi-kondisi akut dan kronis diatur sebagai berikut:

- a) Jika diagnosis utama dicatat sebagai akut (atau subakut) dan kronis, ICD-10 menyediakan kategori atau subkategori yang berbeda untuk masing-masing kategori, tapi tidak untuk gabungannya, kategori kondisi akut harus digunakan sebagai diagnosis utama.

Contoh:

Diagnosis Utama: PPOK dengan eksaserbasi akut

Diagnosis Sekunder: -

Maka kode yang tepat: J44.1 (*Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation*) sebagai diagnosis utama karena disini terdapat kode gabungan akut dan kronis.

- b) Jika di dalam ICD-10 tidak menyediakan kategori atau subkategori yang berbeda untuk masing-masing kategori, maka kondisi akut harus digunakan sebagai diagnosis utama dan kondisi kronis menjadi diagnosis sekunder.

Contoh:

Diagnosis Utama: Gagal ginjal akut dan kronik

Diagnosis sekunder: -

Tindakan: -

Maka kode yang tepat: N17.9 (*Acute Renal Failure, Unspecified*) sebagai diagnosis utama dan gagal ginjal kronik sebagai diagnosis sekunder.

- c) Jika terdapat kondisi lain dimana kondisi akut dan kronis terjadi pada organ/sistem yang berbeda, maka yang dikode sebagai diagnosis utama adalah kondisi yang menghabiskan sumber daya yang paling banyak.

Contoh:

Diagnosis Utama: Gastritis Akut

Diagnosis Sekunder: CKD Stage 5

Tindakan: Hemodialisa

Maka kode yang tepat N18.5 (*Chronic Kidney Disease, Stage 5*) sebagai diagnosis utama, K29.1 (*Other Acute Gastritis*) sebagai diagnosis sekunder dan Hemodialisa sebagai Tindakan.

6) Pengodean kondisi pasca-prosedur dan komplikasinya.

Terdapat 3 jenis kode komplikasi yaitu:

- a) Kode komplikasi pada kelompok kategori komplikasi pada Bab XIX (T80-T88) yang berhubungan dengan operasi dan prosedur lain, Contohnya infeksi luka operasi, komplikasi mekanis benda- benda implantasi, syok, dan lainnya.

Contoh:

Diagnosis Utama:

Perdarahan berlebihan setelah pencabutan gigi.

Diagnosis Sekunder: -

Spesialisasi: Gigi

Kode yang tepat: T81.0 (*Haemorrhage and Haematoma Complicating a Procedures NEC*) sebagai diagnosis utama.

- b) Kode komplikasi yang menggunakan kondisi yang dinyatakan *post-procedural* atau *post-operative*.

Contoh:

Diagnosis Utama:

Hipotiroidisme sejak tiroidektomi 1 tahun yang lalu.

Diagnosis Sekunder: -

Spesialisasi: Penyakit dalam

Kode yang tepat: E89.0

(*Postprocedural Hypothyroidism*) sebagai diagnosis utama.

- c) Kode komplikasi yang menggunakan kode sesuai kondisi yang ada, disertai tambahan kode Y83-Y84 untuk menjelaskan keadaan *post-procedural*.

Contoh:

Diagnosis Utama:

Psikosis pasca-bedah setelah operasi plastik.

Diagnosis Sekunder: -

Spesialisasi: Psikiatri

Kode yang tepat: F09 (*Unspecified Organic or Symptomatic Mental Disorder*) sebagai diagnosis utama dan Y83.8 (*Other Surgical Procedures*) sebagai diagnosis sekunder yang merupakan penyebab dari reaksi abnormal pasien untuk mengindikasikan hubungan pasca bedah.

7) Pengodean untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) (B20-B24).

- (a) Pada pengodean INA-CBG menggunakan kode 4 karakter untuk subkategori pada B20-B23. Penentuan penggunaan subkategori 4 karakter pada B20-B23 atau kode penyebab ganda adalah untuk mengidentifikasi kondisi

yang lebih spesifik.

Contoh :

Diagnosis Utama: Penyakit HIV dan sarkoma Kaposi

Diagnosis Sekunder : -

Kode yang tepat: Dikode B21.0 (*HIV Disease Resulting in Kaposi's Sarcoma*) sebagai diagnosis utama.

- (b) Jika diagnosis utama yang dicatat adalah penyakit HIV dengan multiple penyakit penyerta, maka subkategori .7 dari B20-B22 harus dikode. Subkategori B22.7 harus digunakan apabila terdapat kondisi yang bisa diklasifikasikan pada dua kategori atau lebih pada B20- B22. Kode tambahan dari dalam blok B20-B24 digunakan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh :

Diagnosis Utama:

Toxoplasmosis dan *cryptococcosis* pada pasien HIV

Diagnosis Sekunder:

Dikode B20.7 (*HIV Disease Resulting in Multiple Infections*) sebagai diagnosis utama, B20.8 (*HIV Disease Resulting in Other Infectious and Parasitic Disease*) dan B20.5 (*HIV Disease Resulting in Other Mycoses*) sebagai diagnosis sekunder.

8) Pengodean Neoplasma

- a) Kasus neoplasma baik primer atau sekunder (metastasis) yang merupakan fokus perawatan, harus dicatat dan dikode sebagai diagnosis utama.

Contoh:

Diagnosis Utama. : Karsinoma prostat

Diagnosis Sekunder : Bronkitis kronis

Prosedur : Prostatektomi

Kode yang tepat : C61 (*Malignant Neoplasm of Prostate*) sebagai diagnosis utama dan J42 (*Unspecified Chronic Bronchitis*) sebagai diagnosis sekunder.

- b) Pasien dengan riwayat neoplasma ganas yang tidak mendapatkan tatalaksana menggunakan kode Z85.0 – Z85.9 (*Personal history of malignant neoplasm*).

Contoh:

Diagnosis Utama : *Karsinoma mammae* – diangkat dua tahun yang lalu

Diagnosis Sekunder : Karsinoma sekunder paru-paru

Prosedur : Bronkoskopi dengan biopsi

Kode yang tepat:

C78.0 (*Secondary Malignant Neoplasm Of Lung*) sebagai diagnosis utama, Z85.3 (*Personal History Of Malignant Neoplasm Of Breast*) sebagai diagnosis sekunder.

- c) Pasien yang menjalani pemeriksaan neoplasma karena riwayat keluarga dengan neoplasma ganas, menggunakan kode Z80.0–Z80.9 (*Family history of malignant neoplasm*)

9) Pengodean diabetes mellitus (E10-E14).

Karakter keempat dari kode diabetes mellitus (E10-E14) yaitu sebagai berikut:

- a) Digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5) dan digit 7 (.7) cukup jelas sesuai dengan aturan ICD-10 Versi Tahun 2010.

Diagnosis Utama: Gagal ginjal akibat *glomerulonefrosis diabetes*

Diagnosis Sekunder: -

Kode yang tepat: E14.2+ dan N08.3* (*Unspecified Diabetes Mellitus With Renal Complications*)

- b) Digit 6 (.6) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi spesifik lainnya selain yang terdapat pada digit 0 sampai digit 5 (.0 sampai .5). Keterangan pada digit 6 (.6) dalam ICD-10 hanya merupakan sebagian contoh kasus karena tidak terdapat lambang *dagger* (†) setelah digit keempat.

Contoh:

Diagnosis Utama: *Lancereaux's diabetes*

Diagnosis Sekunder: -

Kode yang tepat: E14.6 (*Unspecified Diabetes Mellitus with Other Specified Complications*)

sebagai diagnosis utama.

- c) Digit 8 (.8) digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi yang tidak dijelaskan atau tidak spesifik.
- d) Digit 9 (.9) digunakan jika diabetes mellitus tanpa komplikasi.

Contoh:

Diagnosis Utama: Diabetes mellitus tipe II

Diagnosis Sekunder: -

Kode yang tepat:

E11.9 (*Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus without Complications*) sebagai diagnosis utama

10) Pengodean Persalinan (O80-O84)

- a) Kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder untuk menunjukkan metode persalinan.
- b) Jika tidak terdapat komplikasi atau penyulit persalinan lainnya maka kode O80-O84 (*Delivery*) digunakan sebagai diagnosis utama.
- c) Kode Z37.0 – Z37.9 (*Outcome of delivery*) digunakan sebagai diagnosis sekunder.

Contoh:

Diagnosis Utama : Persalinan

Diagnosis Sekunder : Kegagalan percobaan persalinan

Prosedur : Seksio Sesar

Kode yang tepat : O66.4 (*Failed Trial of Labour, Unspecified*) sebagai diagnosis utama. O82.9 (*Delivery by Caesarean Section, Unspecified*) dan Z37.- (*Outcome of Delivery*) sebagai diagnosis sekunder.

8. Tata Cara Koding

Secara legal, pemberlakuan ICD-10 di Indonesia mengacu pada SK Menkes RI Nomor: 50/MENKES/I/1998 tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh. Berikut peraturan umum dalam menentukan kode pada ICD-10 adalah sebagai berikut (WHO, 2010; Hatta, 2017):

- a. Tentukan tipe pernyataan yang akan dikode buka volume 3 Alfabetical Index. Bila pernyataan adalah istilah lain yang terdapat pada bab I-XIX dan XXI (Volume 1) gunakanlah sebagai lead-term untuk digunakan sebagai panduan menelusuri istilah yang dicari pada seksi I indeks, (Volume 3). Bila pernyataan adalah penyebab luar (external cause) dari cedera (bukan nama penyakit) yang ada di Bab XX (Volume 1), lihat dan cari kode pada seksi II di indeks (Volume 3).
- b. "*Lead term*" untuk penyakit dan cedera biasanya kata benda yang memaparkan kondisi patologisnya. Sebaiknya jangan menggunakan kata benda anatomi, kata sifat atau kata keterangan sebagai kata panduan. Namun, beberapa kondisi lain diekspresikan sebagai kata sifat (eponim/menggunakan nama penemu) yang

- tercantum di dalam Index sebagai "*lead term*"
- c. Baca dengan seksama dan ikuti petunjuk catatan yang muncul dibawah istilah yang akan dipilih pada Volume 3.
 - d. Baca istilah yang terdapat dalam tanda kurung "()" sesudah *lead term* (kata tanda kurung = *modifier*, tidak akan mempengaruhi kode). Istilah lain yang ada dibawah lead term (dengan tanda (-) minus = idem = *indent*) dapat mempengaruhi nomor kode sehingga semua kata-kata diagnostik harus diperhitungkan).
 - e. Ikuti secara hati-hati setiap rujukan silang (*cross reference*) dan perintah *see* dan *see also* yang terdapat dalam indeks.
 - f. Lihat daftar tabulasi (Volume 1) untuk mencari nomor kode yang paling tepat. Lihat kode tiga karakter di indeks dengan tanda minus pada posisi keempat yang berarti bahwa isian untuk karakter keempat itu ada di Volume1 dan merupakan posisi tambahan yang tidak ada dalam indeks (Volume 3). Perhatikan juga perintah untuk membubuhi kode tambahan (*additional code*) serta aturan cara penulisan dan pemanfaatannya dalam pengembangan indeks penyakit dan dalam sistem pelaporan morbiditas dan mortalitas.
 - g. Ikuti pedoman *inclusion* dan *exclusion* pada kode yang dipilih atau bagian bawah suatu bab (*chapter*), blok, kategori, atau subkategori.
 - h. Tentukan kode yang dipilih.

B. Kode Prosedur Medis (ICD-9CM)

1. Pengertian

ICD 9 pertama kali diterbitkan oleh WHO pada tahun 1975. Terdiri dari dua volume, volume pertama berisi indeks alfabetik dan daftar tabulasi dengan suplemen kode V dan E (yang kemudian menjadi bab XXI dan XX pada revisi tahun 2010).

WHO mengeluarkan *International Classification of Procedures in Medicine* (ICPM) bersamaan dengan publikasi ICD-9. ICPM terdiri dari 2 volume dan 9 bab, dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti ICD-9 dan berisikan kode-kode prosedur laboratorium, radiologi, operasi (pembedahan), terapi, dan pemeriksaan diagnostik lainnya.

ICD 9 – CM (*The International Classification of Diseases, 9th Revision – Clinical Modification*) merupakan bentuk adaptasi khusus dari ICD Revisi ke-9 WHO, yang dibuat oleh U.S. *National Center for Health Statistics* (NCHS) dan khusus digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1978, bersamaan dengan dipublikasikannya ICD-9 dan ICPM oleh WHO. Di Indonesia kode prosedur bedah dan non bedah menggunakan ICD-9CM. Di era implementasi sistem casemix berbasis INA-CBG, kode ICD-9CM menjadi komponen dalam (Presiden RI, 2013).

2. Struktur dan Isi ICD-9CM

ICD-9CM Terdiri dari 3 volume:

- a. *Volume 1 – Diseases : Tabular list*
- b. *Volume 2 – Diseases : Alphabetical list*
- c. *Volume 3 – Procedures : Tabular & Alphabetical Index*

Sebagaimana versi aslinya dari WHO, ICD-9CM hanya berisi kode numerik, yang berbasis struktur 2-digit dengan 2 digit desimal bila perlu (ekspansi dari 3 digit pada ICD-9 menjadi 4 digit pada ICD -9CM).

ICD-9CM versi 2010 untuk Prosedur Medis terdiri dari 17 Bab, mulai dari kategori 00 s/d 16. Semua daftar tabulasi dalam ICD-9CM untuk prosedur medis disusun berdasarkan body sistem, kecuali 3 bab ini:

- a. Bab 00 : Prosedur dan intervensi, tidak terklasifikasi di tempat lain
- b. Bab 13 : Prosedur obstetrik
- c. Bab 16 : prosedur diagnostik dan terapeutik lain-lain.

3. Prinsip Koding Prosedur Medis

Koding prosedur medis bersifat multipel. Hal ini diartikan, semua prosedur signifikan yang telah dilakukan sejak saat admisi hingga pulang harus didokumentasikan, meliputi prosedur diagnostik, terapeutik dan penunjang. Prosedur pemeriksaan yang dikode adalah yang relevan, meliputi semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, yang

dianggap membawa/ memberikan pengaruh terhadap manajemen pasien pada episode perawatannya.

Prosedur utama adalah prosedur yang paling signifikan, yang dilakukan untuk mengobati/mengatasi diagnosis utama. Oleh karena itu harus ada kesesuaian antara kode prosedur dengan kode diagnosis.

4. Jenis Prosedur Medis

Dalam ICD-9CM Prosedur medis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Non operative procedure*

Prosedur terapeutik dan investigasi lain yang tidak melakukan manipulasi terhadap bagian tubuh dan sangat sedikit invasif. Misalnya pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium, pemeriksaan fisik, psikologis, dan prosedur penunjang lainnya. Bagian terbesar dari prosedur ini terklasifikasi dalam bab 16 ICD-9CM yaitu: *Miscellaneous Diagnostic and Therapeutic Procedures*.

b. *Operative procedure*

Suatu operasi didefinisikan sebagai prosedur terapeutik atau diagnostik mayor apapun yang melibatkan penggunaan instrumen atau manipulasi sebagian tubuh, dan secara umum dilakukan dalam kondisi OT dan atau dibawah GA, selain persalinan normal pada pasien obstetri. Prinsip operasi dilakukan untuk merawat kondisi yang terpilih sebagai diagnosis utama.

Prosedur operasi dibedakan menjadi 2 macam:

1) *OR Procedure / Operation Room*

Semua tindakan atau prosedur yang dilakukan di kamar operasi, melibatkan peralatan khusus, SDM khusus dan resource yang besar. Ditandai dengan blok khusus berwarna pada ICD-9CM.

2) *Non OR Procedure / non operation Room*

Semua prosedur yang dilakukan diluar kamar operasi, namun membutuhkan skill atau ketrampilan khusus dari tenaga kesehatannya dan atau peralatannya yang mahal. Ditandai dengan blok khusus tidak berwarna.

5. Tata Cara Koding Prosedur Medis

- a. Pada saat memberikan kode laporan operasi, koder harus membaca dengan seksama seluruh laporan operasi dan mencatat atau menggaris bawahi kemungkinan adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh dokter dalam laporan operasi, koder harus mengklarifikasi hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan.
- b. Jika ditemukan diagnosa *pre operative* dan *post operative* berbeda maka gunakan diagnosis *post operative*.
- c. Periksa laporan patologi, bila terdapat perbedaan antara diagnosis patologis dan Spesialis Bedah, maka sebaiknya didiskusikan dengan kedua pihak.

- d. Langkah-langkah koding:
- 1) Carilah dalam indeks alfabetik nama prosedur, atau eponimnya
 - 2) Cross cek ke dalam daftar tabulasi
 - 3) Ikuti catatan-catatan khusus (konvensi) dalam daftar tabulasi
 - 4) Pilih kode dengan tingkat rincian tertinggi. Kode paling spesifik mencakup 4 digit

6. Ketentuan Koding Prosedur Medis

a. Pembatalan prosedur

Apabila suatu operasi yang direncanakan tidak berjalan sepenuhnya, maka koder harus mengkode sejauh mana operasi dilaksanakan, yaitu ;

- 1) Jika suatu prosedur dibatalkan setelah pasien dirawat inap di RS dan pasien tersebut belum dipersiapkan untuk operasi maka kode prosedurnya tidak dilaporkan.
- 2) Jika suatu operasi terjadwal dihentikan setelah pasien siap atau sedang dilakukan operasi, maka dianggap sebagai tindakan yang tidak lengkap / tidak sesuai.

Berikut contoh tatacara koding untuk tindakan operasi yang tidak lengkap:

Kasus 1:

Pasien masuk rawat inap untuk dilakukan partial gastrectomy akibat ulcus gastro perforasi. Baru saja

dokter bedah selesai melakukan insisi abdomen, anesthesiologi mengingatkan dokter bedah bahwa pasien mengalami distress respirasi. Dokter bedah menutup kembali insisi abdomen dan pasien dipindahkan ke ruang ICU.

Solusi:

Koder memberikan kode 54.0 untuk insisi dinding abdomen, bukan di kode dengan partial *gastrectomy* karena tindakan medis belum dilakukan.

Kasus 2:

Misalnya pasien dijadwalkan untuk tindakan operasi akibat ureteritis berat, setelah dilakukan anestesi dan pasien dipersiapkan untuk *endoscopic biopsy ureter* kanan. *Endoscopy* dapat masuk dengan mudah kedalam kandung kemih, tetapi tidak bisa masuk lebih jauh kedalam ureter akibat adanya sumbatan. Dokter bedah kemudian mencabut kembali endoskop dan memindahkan pasien keruang pemulihan.

Solusi:

Koder memberikan kode 57.32 (*cystoscopy*) karena prosedur biopsi ureter tidak dilakukan.

b. Penggunaan kode kombinasi dan kode ganda

Kode kombinasi adalah kode tunggal untuk mengklasifikasi 2 prosedur. Kode kombinasi dapat ditemukan dengan merujuk pada *subterm* pada indeks

prosedur dan dengan membaca konvensi *include* dan *exclude* pada daftar tabulasi.

Kode ganda diberikan apabila tidak mencakup prosedur yang dilakukan. Contohnya:

28.2	Tonsillectomy without adenoidectomy
28.3	Tonsillectomy with adenoidectomy
28.4	Excision of tonsil tag
28.5	Excision of lingual tonsil
28.6	Adenoidectomy without tonsillectomy Excision of adenoid tag

Gambar 3.5 Kode Kombinasi

Sumber: Buku ICD-9CM

Perhatikan bahwa kode 28.2 adalah untuk "*tonsillectomy without adenoidectomy*", sedangkan kode 28.6 adalah untuk "*adenoidectomy without tonsillectomy*". Jika dilakukan operasi "*tonsillectomy with adenoidectomy*" janganlah mengkode dengan 28.2 dan 28.6, tapi beri kode 28.3 untuk prosedur "*tonsillectomy and adenoidectomy*" karena deskripsi kode tersebut telah mencakup keduanya.

c. Pengangkatan Organ

- 1) Jika pengangkatan suatu organ penuh :

Excision / Resection

pilih lokasi anatomik / nama organ

- 2) Jika pengangkatan suatu lesi (bagian dari organ):

Excision

Lesion

pilih lokasi anatomik/nama organ

- 3) Jika diketahui nama prosedurnya (eponym):

Operation

Nama/eponym nya

d. Perubahan prosedur

- 1) Apabila dilakukan prosedur tertutup seperti *laparoscopic, thoracoscopic* atau *arthroscopic* diubah menjadi tindakan bedah terbuka maka cukup dikode operasi terbukanya saja. Prosedur tertutup menggunakan endoskopi untuk melihat area dan instrumen-instrumen dimasukkan melalui endoskop untuk menyelesaikan prosedur.
- 2) Apabila dilakukan prosedur terbuka merupakan tindakan insisi melalui lapisan kulit, jaringan bawah kulit dan mungkin otot untuk membuka area tubuh yang perlu di operasi (misalnya *abdominal hysterectomy*).

e. Prosedur Endoskopi

Jika prosedur endoskopi melalui lebih dari 1 rongga tubuh, beri kode menurut letak terjauh. Misalnya endoskopi untuk esofagus dan lambung, maka di kode sebagai endoskopi lambung 44.13 (*gastroscopy*).

f. Prosedur Biopsi

Apabila memberikan kode biopsi, review rekam medis pasien perlu dilakukan untuk menentukan tipe biopsi yang dilakukan:

- 1) Tertutup (*closed*)

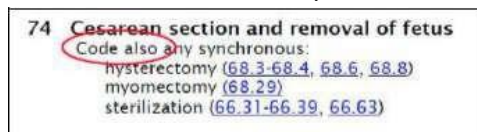
Dilakukan secara *percutaneus*, menembus kulit, dengan aspirasi, bristle atau dengan sikat, endoskop, atau jarum. ICD-9CM mengklasifikasi sebagian besar kode biopsi tertutup dengan kode kombinasi. Namun jika kode kombinasi untuk suatu biopsi melalui endoskop (misalkan *endoscopic biopsy of uretra*) tidak tersedia dalam daftar tabulasi, maka gunakan dua kode. Kode untuk endoskopi dilaporkan terlebih dahulu karena lebih signifikan dan lebih beresiko, baru kode biopsi.

2) Terbuka (*open*)

Dilakukan melalui *incisi*. Untuk biopsi terbuka, harus dipahami bahwa incisi sudah termasuk dalam kode biopsi, meskipun deskripsi kode nya tidak menyatakan demikian. Misalnya jika dilakukan incisi pada kulit untuk biopsi tulang, maka yang dikode cukup biopsi tulangnya saja, dengan asumsi dokter bedah tentu perlu melakukan *incisi* pada kulit untuk bisa menjangkau tulang.

g. Code also

Instruksi *code also* dalam daftar tabulasi berarti “beri kode ini juga bila prosedur lain dilakukan”. Jadi menambahkan kode selain kode prosedur utama.



Gambar 3.6 Code Also

Sumber: Buku ICD-9CM

h. **Omit Code**

Apabila terdapat keterangan *omit code* dibelakang terminologi utama atau sub term, maka prosedur tersebut tidak dikode karena dianggap sebagai pendahuluan atau bagian integral dari suatu prosedur. Jangan pula di kode untuk tindakan membuat irisan atau menutup luka operasi atau pemberian anestesi pada operasi, karena merupakan bagian dari operasi.

Incision (and drainage) with exploration --see Exploration removal of foreign body --see Removal, foreign body abdominal wall 54.0 as operative approach --omit code abscess --see also Incision, by site	54.0 Incision of abdominal wall Drainage of: abdominal wall extraperitoneal abscess retroperitoneal abscess <i>Excludes:</i> Incision of peritoneum (54.95) laparotomy (54.11-54.19)
--	---

Gambar 3.7 Omit Code

Sumber: Buku ICD-9CM

Indeks prosedur "*Incision (and drainage) abdominal wall, as operative approach*" menginstruksikan pada koder untuk menghilangkan kode (*omit code*) untuk operasi pendahuluan pada dinding abdomen, jika ada prosedur lain yang definitif.

Operasi pendahuluan diberikan kode jika prosedur membuka rongga tubuh (misalnya *laparotomy eksplorasi*) diikuti oleh prosedur diagnostik (misalnya biopsi lambung) dan tidak dilakukan prosedur terapeutik. Untuk ini, kode *laparotomy* dimasukkan terlebih dulu, diikuti oleh kode biopsi, karena tindakan

membuka rongga tubuh dianggap lebih signifikan daripada biopsy. Karena pada umumnya laparotomi merupakan *omit code* jika menjadi pendahuluan dari operasi.

Laparotomy NEC [54.19](#)
as operative approach -- omit code
exploratory (pelvic) [54.11](#)
reopening of recent operative site
(for control of hemorrhage)
(for exploration) (for incision of
hematoma) [54.12](#)

Gambar 3.8 Omit Code pada Laparotomi

Sumber: Buku ICD-9CM

Bab 4

Permasalahan Kualitas Kode Klinis

A. Permasalahan Pending Klaim BPJS Kesehatan

1. Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan

Proses klaim sangatlah penting bagi rumah sakit sebagai penggantian biaya pasien asuransi yang telah selesai melakukan pengobatan atau perawatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan harus mampu memberikan pengajuan klaim setiap bulan secara konsisten dan paling lambat pada tanggal 10 pada bulan selanjutnya (BPJS Kesehatan, 2015).

Pending klaim merupakan berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit kepada verifikator BPJS Kesehatan, namun berkas dikembalikan karena terdapat persyaratan yang kurang. Pengajuan klaim ini tentunya harus dilengkapi dengan berkas persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan syarat dan prosedur verifikasi dari BPJS Kesehatan. Dengan maksud lain, rumah sakit

harus melakukan revisi dan melengkapi persyaratan untuk diajukan kembali kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil literatur riview dampak akibat terjadinya pending klaim terhadap rumah sakit diantaranya terganggunya arus pendanaan rumah sakit yang mana rumah sakit telah memberikan pelayanan namun akibat terpending dan belum bisa dibayarkan oleh pihak BPJS, pending klaim juga berdampak pada jasa medis petugas juga akan berkurang dan juga akan menyita waktu petugas untuk merivisi kembali berkas yang pending agar dana pending bisa dicairkan (Oktamianiza etall, 2021). Pending klaim/penundaan klaim juga dapat mengakibatkan *cashflow* rumah sakit terganggu, dan akan berdampak secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan pasien terkait ketersediaan obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana (Kodyat.A.G etall, 2020). Selain itu dampak pending klaim bagi rumah sakit yaitu berdampak pada keuangan Rumah Sakit serta menyebabkan tidak tepatnya waktu pembagian jasa medis dokter dan jasa pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan pelayanan dan pembiayaan rumah sakit (Pratama.A. etall, 2023).

Penyebab klaim menjadi pending atau ditolak karena masih terdapat berkas yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan dari verifikator BPJS Kesehatan, yang demikian apabila berkas mengalami revisi maka proses klaim akan. Berdasarkan SE Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penatalaksanaan Penyelesaian Dispute Klaim Dalam Penyelenggaraan JKN, dijelaskan bahwa Dispute Klaim merupakan klaim atas pelayanan kesehatan yang belum dapat disetujui pembayarannya oleh BPJS Kesehatan dikarenakan adanya ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan atas klaim tersebut sesuai berdasarkan berita acara pengajuan klaim (BPJS Kesehatan, 2016).

Adapun permasalahan klaim BPJS Kesehatan berdasarkan SE Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 yang menjadi faktor penyebab terjadinya pending klaim (*dispute klaim*) yaitu diantaranya (BPJS Kesehatan, 2016):

a. Aspek Coding

Penyebab terjadinya pending klaim (*dispute claim*) dari aspek coding disebabkan karena adanya ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL terkait tata koding INA-CBG.

b. Aspek Medis

Adanya ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL terkait masalah medis (*medical advice*)

yang tidak sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) atau belum adanya PPK.

c. Aspek Administrasi

Adanya ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL terkait administrasi klaim.

2. Penatalaksanaan Solusi Penyelesaian Klaim INA-CBG

Untuk mengatasi permasalahan terkait kasus klaim dispute dan pending serta proses verifikasi klaim INA-CBG. Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan menetapkan kesepakatan bersama untuk panduan penatalaksanaan solusi permasalahan klaim INA-CBG yang dituangkan melalui berita acara dan ditandatangani oleh Kepala PPK Kemenkes RI dan Deputi Direksi Bidang JPK Rujukan BPJS Kesehatan. Berita acara ini telah disusun dan saat ini sudah dilakukan perbaharuan berita acara ketiga pada tahun 2019, dengan nomor: JP.02.03/3/1693/2020. Pembahasan panduan penatalaksanaan solusi permasalahan klaim INA-CBG tahun 2019, telah diseapakati diagnosis dan tindakan prioritas yang terdiri dari aspek coding, aspek medis dan aspek administrasi.

Penyelesaian klaim ini merupakan keputusan bersama yang telah disepekat oleh Kementerian Kesehatan RI bersama BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Profesi Dokter Spesialis. Berita acara ini juga akan menjadi acuan untuk penyelesaian permasalahan klaim INA-CBG yang

mengalami pending atau pembayarannya masih tertunda dan masih dalam proses verifikasi. Masalah pending klaim yang sering terjadi menyangkut pada tiga aspek yaitu:

a. Aspek Administrasi

Administrasi klaim merupakan kelengkapan berkas klaim yang terdiri dari Surat Eligibilitas Peserta (SEP), bukti pelayanan dan data kepesertaan yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai persyaratan dalam proses pengajuan klaim BPJS. Berkas tersebut harus dilengkapi untuk ditujukan kepada verifikator BPJS kesehatan untuk dilakukan proses verifikasi (Amir.B.I etall, 2020).

Sesuai dengan (BPJS Kesehatan, 2018) menyatakan bahwa kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan FKRTL adalah sebagai berikut:

- 1) Lembar SEP yang ditandatangani oleh peserta/keluarga atau cap jempol tangan peserta
- 2) Resume medis yang mencamtukan diagnosa dan prosedur yang ditandatangani oleh DPJP
- 3) Laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi
- 4) Hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan
- 5) Surat perintah rawat inap
- 6) Surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegah kecurangan rumah sakit
- 7) Checklist klaim rumah sakit

- 8) Luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah pada sistem informasi BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2018).

Berdasarkan BA Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019 terdapat 11 aspek administrasi yang perlu diperhatikan, berikut contoh salah satu aspek administrasi:

Diagnosis

Pada kasus Haemofilia, harus ada rujukan balik (protokol terapi) dari PPK 3 dan surat rujukan menyusul, tidak bisa diklaimkan sebagai kasus Haemofilia.

Perihal Administrasi

-

Solusi Administrasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK. 02.02/MENKES.523/2015 bahwa Peresepan Produk Darah Faktro VIIa (rekombinan), hanya boleh diberikan oleh hematolog dewasa atau hematolog anak.

Yang diterima adalah kasus dengan protokol terapi yang sudah ada namun tidak dibawa. Untuk yang belum ada protokol terapi dan tidak ada pengakkan diagnosis dari PPK 3 sebelumnya, tidak diberikan penaminan.

Perhatian Khusus

-

Keterangan

BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

b. Aspek *Coding*

Coding merupakan kegiatan memberikan kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD 10 dan ICD 9 CM untuk kode prosedur. Kegiatan coding merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam sistem pembiayaan prospektif, yang mana coding akan menentukan besarnya biaya yang dibayarkan ke rumah sakit (Kemenkes RI, 2014).

Dispute pada aspek *coding* ini adalah *dispute* atas klaim pelayanan kesehatan karena adanya ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) terkait tata *coding* INA-CBG (BPJS Kesehatan, 2016). Berikut ini adalah contoh kasus pending klaim aspek *coding* berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023 (BPJS Kesehatan, 2023):

Diagnosis:

Kasus Bab XV. Kehamilan, Persalinan dan Masa Nifas

Persalinan normal pada peserta dengan riwayat SC dikode sebagai *maternal care due to uterine scar from previous surgery* (034.2), seharusnya menggunakan *vaginal delivery following previous cesarean section* (075.7).

Aspek Coding

Mengacu aturan kode kombinasi ICD-10 pada kode O34.2 terdapat pengecualian apabila persalinan normal pada peserta dengan riwayat SC (075.7).

Advanced Search]	ICD-10	Versions - Languages	Info	
-------------------	--------	----------------------	------	--

034.2 Maternal care due to uterine scar from previous surgery

Maternal care for scar from previous caesarean section

Excl.: vaginal delivery following previous caesarean section NOS ([075.7](#))

Gambar 4.1 Kasus Kode Kombinasi Persalinan

Sumber: Volume I ICD-10

Prosedur

-

Perhatian Khusus

Penegakkan diagnosis sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023 maka kode

yang sesuai vaginal delivery following previous caesarean section (075.7).

Keterangan

BA Kesepakatan Bersama Tahun 2023

c. Aspek Medis

Aspek medis dalam kegiatan klaim dapat berhubungan dengan pengisian diagnosis penyakit dan prosedur tindakan. Dispute pada aspek medis merupakan dispute atas klaim pelayanan kesehatan dengan FKRTL terkait masalah medis (medical advice) yang tidak sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) atau belum terdapat PPK (BPJS Kesehatan, 2016). Dalam BA Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019 terdapat 69 aspek medis yang harus diperhatikan, berikut contoh salah satu aspek medis:

Diagnosis

Diagnosis sekunder Syok Kardiogenik pada kasus meninggal

Prosedur

-

Aspek Medis

Kondisi Syok Kardiogenik dapat menjadi diagnosis sekunder, terutama pada pasien penyakit jantung dengan bukti tertulisnya kriteria klinis dalam rekam medis, berupa:

- 1) Penurunan Tekanan Darah
 - a) TD < 90 mmHg tanpa inotropik, atau
 - b) TD < 80 mmHg dengan inotropik
- 2) Penurunan Ejection Fraction (EF < 50%)

Perhatian Khusus

Tidak boleh di coding bila tidak tegak secara medis dan tidak ada *resource* khusus.

Keterangan

BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018

B. Permasalahan Kualitas Kode Klinis Pada Sistem Casemix

Dalam era transformasi digital di bidang kesehatan, sistem casemix menjadi komponen kunci dalam manajemen biaya dan efisiensi pelayanan kesehatan. Sistem ini berfungsi untuk mengelompokkan pasien berdasarkan karakteristik klinis dan kebutuhan perawatan, sehingga memudahkan dalam proses penagihan dan perencanaan sumber daya. Kualitas kode klinis yang digunakan dalam sistem casemix sangat mempengaruhi akurasi data dan hasil analisis pembiayaan. Permasalahan kualitas kode klinis pada implementasi sistem casemix meliputi:

1. Ketidakuratan Pengodean Berdasarkan Prinsip Umum (*General Principle*)

Permasalahan ketidakakuratan berdasarkan prinsip umum (*General Principle*) menunjukkan adanya ketidakakuratan pemberian kode sesuai yang ditegakkan dokter.

Contoh:

Diagnosis Utama: *Hernia inguinal* kanan kiri

Coder memberikan kode K40.9 (*Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene*) sebagai diagnosis utama

Hasil kode ditolak verifikator, Klaim pending.

Klarifikasi: pada kasus tersebut coder seharusnya memberikan kode K40.2 (*Bilateral inguinal hernia, without obstruction or gangrene*) sebagai diagnosis utama.

K40	Inguinal hernia
	Incl.: bubonocele inguinal hernia: • NOS • direct • double • indirect • oblique scrotal hernia
K40.0	Bilateral inguinal hernia, with obstruction, without gangrene
K40.1	Bilateral inguinal hernia, with gangrene
K40.2	Bilateral inguinal hernia, without obstruction or gangrene Bilateral inguinal hernia NOS
K40.3	Unilateral or unspecified inguinal hernia, with obstruction, without gangrene Inguinal hernia (unilateral): • causing obstruction • incarcerated • irreducible • strangulated without gangrene
K40.4	Unilateral or unspecified inguinal hernia, with gangrene Inguinal hernia NOS with gangrene
K40.9	Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene

Gambar 4.2 Kasus *General Principle*

Sumber: Volume I ICD-10

2. Ketidakakuratan Kode Diagnosis Kombinasi Sesuai Kaidah ICD-10

Permasalahan ketidakakuratan kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10 dapat berdampak pada perbedaan biaya klaim.

Contoh:

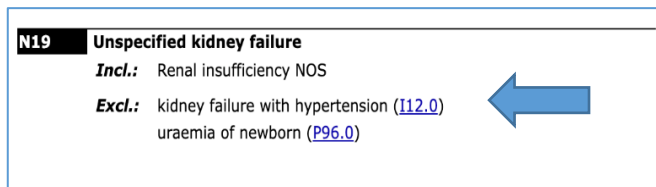
Diagnosis Utama: Hipertensi

Diagnosis sekunder: Gagal ginjal

Coder memberikan kode I10 (*Hypertension*) sebagai diagnosis utama dan N19 (*Kidney Failure*) sebagai diagnosis sekunder

Hasil kode ditolak verifikator, Klaim pending.

Klarifikasi: pada kasus tersebut sesuai Volume 1 ICD-10 terdapat catatan kode kombinasi pada penggunaan kode N19, yaitu pengecualian apabila gagal ginjal dengan hipertensi maka menggunakan kode tunggal I12.0.



Gambar 4.3 Kasus Kode Kombinasi

Sumber: Volume I ICD-10

3. Ketidakakuratan Kode Diagnosis Ganda Sesuai Kaidah ICD-10

Permasalahan yang ditemukan di rumah sakit berkaitan ketidakakuratan kode diagnosis ganda sesuai kaidah

ICD-10 dapat berdampak pada kegagalan melaporkan informasi penyebab gangguan atau diagnosis pada klaim pembiayaan pasien. Kode ganda dagger (+) dan asterik (*) pada implementasi sistem casemix sudah diantisipasi dengan melalui pemberian alert/notifikasi error pada aplikasi INA-CBG. Hal ini tentunya sangat membantu coder dalam mencegah kegagalan pemberian kode ganda dagger (+) dan asterik (*). Secara singkat dapat disampaikan algoritma sistem pada aplikasi INA-CBG sudah berbasis *decision support system* dengan menempatkan kode dagger (+) sebagai diagnosis utama dan kode asterik (*) sebagai diagnosis sekunder.

Berikut permasalahan ketidakakuratan kode ganda:

a. Kode Agen Penyebab Infeksi

Untuk infeksi lokal, yang terklasifikasi dalam bab "*body systems*", dengan blok kategori, B95–B98, disediakan dalam Bab I. Contoh kasus masalah kode ganda pada agen penyakit infeksi adalah pasien diagnosis *Prostatitis*. Hasil Lab menunjukkan terdapat bakteri *Escherichia coli* (+), coder memberikan kode N41.9.

Klarifikasi: Pada kasus tersebut coder seharusnya menentukan kode sesuai bukti dokumentasi penunjang klinis, yaitu Hasil Lab: *Escherichia coli* (+), yang berarti kasus pasien adalah *Prostatitis* akibat

bakteri *Escherichia coli*, sehingga kode yang digunakan :

KU: *Prostatitis*, diberikan kode N41.9.

KL: *Escherichia coli*, diberikan kode B6.2

N41	Inflammatory diseases of prostate Use additional code (B95-B98), if desired, to identify infectious agent.
N41.0	Acute prostatitis
N41.1	Chronic prostatitis
N41.2	Abscess of prostate
N41.3	Prostatocystitis
N41.8	Other inflammatory diseases of prostate
N41.9	Inflammatory disease of prostate, unspecified Prostatitis NOS

Gambar 4.4 Kasus Kode Ganda Agen Penyebab Infeksi

Sumber: Volume I ICD-10

Berdasarkan Volume 1 ICD-10 (gambar 3.4) terdapat catatan bahwa pada kode N41 dapat menggunakan kode B95-B98 jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi agen penyebab infeksius.

**Bacterial, viral and other infectious agents
(B95-B98)**

Note: These categories should never be used in primary coding. They are provided for use as supplementary or additional codes when it is desired to identify the infectious agent(s) in diseases classified elsewhere.

B95	Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B95.0	Streptococcus, group A, as the cause of diseases classified to other chapters
B95.1	Streptococcus, group B, as the cause of diseases classified to other chapters
B95.2	Streptococcus, group D, as the cause of diseases classified to other chapters
B95.3	Streptococcus pneumoniae as the cause of diseases classified to other chapters
B95.4	Other streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B95.5	Unspecified streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B95.6	Staphylococcus aureus as the cause of diseases classified to other chapters
B95.7	Other staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B95.8	Unspecified staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B96	Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters
B96.0	Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters Pleuro-pneumonia-like-organism [PPL0]
B96.1	Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters
B96.2	Escherichia coli [E. coli] as the cause of diseases classified to other chapters

Gambar 4.5 Kasus Kode Ganda Agen Penyebab Infeksi

Sumber: Volume I ICD-10

Berdasarkan Volume 1 ICD-10 (gambar 4.5) terdapat catatan kode ganda pada penggunaan kode B95-B98, bahwa kategori kode B95-B98 tidak digunakan sebagai kode utama (primer) untuk mengklasifikasikan penyakit, melainkan digunakan sebagai kode tambahan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang agen infeksius yang menyebabkan penyakit tersebut. Dengan demikian kode B96.2 *Escherchia coli* digunakan sebagai kode sekunder.

b. Kode morfologi pada neoplasma

Permasalahan umum yang terjadi adalah pada kasus neoplasma coder hanya memberikan kode topografinya saja, dan tidak memberikan morfologi. Contoh Carcinoma larynx (primary site), hanya di kode C32.9 tanpa kode M8070/3.

Klarifikasi: permasalahan tersebut tidak berdampak pending klaim, dengan catatan hasil pathology anatomi sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan DPJP.

Menurut kaidah coding ICD-10 kode morfologi menjadi bagian penting untuk menentukan ketepatan kode topografi (Maesaroh, Sudra and Arief, 2011; Putu Anda Tusta Adiputra, 2016).

c. Penyebab Gangguan Mental Organik

Permasalahan pada gangguan mental organik umumnya pada kode yang terklasifikasi dalam F00–F09 (*Organic, including symptomatic, mental disorders*) dimana coder tidak menyertakan kode penyebab gangguan mental organik.

Klarifikasi: permasalahan tersebut tidak berdampak pending klaim, dengan catatan spesialisasi DPJP sesuai dengan diagnosis dan bukti penatalaksanaan klinis.

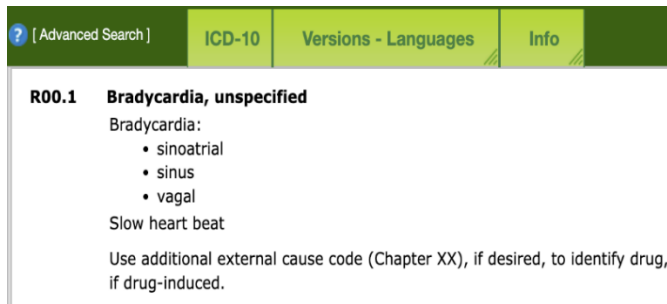
Kode F00-F09 dapat ditambahkan kode lain untuk menunjukkan penyebabnya, misalnya penyakit yang mendasari, cedera atau gangguan lain pada otak (WHO, 2010).

d. Agen Toksik

Permasalahan yang terjadi umumnya pada suatu kondisi yang disebabkan oleh agen toksik, tidak identifikasi agen sehingga kode drug tidak diberikan. Contoh: pasien laki-laki mengalami *bradycardia* akibat konsumsi obat anti depresan karena terapi kejiwaan. Coder hanya memberikan kode R00.1.

Klarifikasi: *Bradycardia, unspecified* diberikan kode R00.1, kecuali pada kondisi abnormalitas yang disebabkan pada masa perinatal gunakan kode P29.1, Aritmia yang sudah spesifik gunakan kode I47-I49. Pada R00.1 terdapat catatan *Use additional external cause code (Chapter XX, if desired, to*

identify drug-induced), sehingga kode akhir adalah R00.1, Y49.2



Gambar 4.6 Kasus agen toksik

Sumber: Volume I ICD-10

e. Kode Sebab Luar

Permasalahan umum yang terjadi pada kasus sebab luar adalah coder hanya memberikan kode penyebab kejadian tanpa menjelaskan kode lokasi dan aktivitas. Contoh: Pada rekam medis tertulis:

Anamnesis: Jam 19.00 Pasien kecelakaan tunggal naik sepeda motor jatuh di jalan kampung saat mau beli makan.

Diagnosis: *Fracture* femur terbuka

Hasil radiologi: *Fracture* femur distal

Coder memberikan kode: S72.9, V18

Klarifikasi: Sebelum menentukan kode fracture femur terbuka, coder perlu membaca hasil radiologi. Pada kasus tersebut fracture terdapat pada bagian femur distal (bawah), sehingga kode yang tepat adalah S72.41 (*Fracture of lower end of femur*).

S72	Fracture of femur
	The following subdivisions are provided for optional use in a supplementary character position where it is not possible or not desired to use multiple coding to identify fracture and open wound; a fracture not indicated as closed or open should be classified as closed.
	0 closed
	1 open
S72.0	Fracture of neck of femur Fracture of hip NOS
S72.1	Pertrochanteric fracture Intertrochanteric fracture Trochanteric fracture
S72.2	Subtrochanteric fracture
S72.3	Fracture of shaft of femur
S72.4	Fracture of lower end of femur
S72.7	Multiple fractures of femur
S72.8	Fractures of other parts of femur
S72.9	Fracture of femur, part unspecified

Gambar 4.7 Kasus Cedera

Sumber: Volume I ICD-10

Sedangkan untuk kode kecelakaan tunggal naik sepeda motor jatuh di jalan kampung, seharusnya V18.04.

Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19)

The following fourth-character subdivisions are for use with categories V10-V18:

- .0 Driver injured in nontraffic accident
- .1 Passenger injured in nontraffic accident
- .2 Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
- .3 Person injured while boarding or alighting
- .4 Driver injured in traffic accident
- .5 Passenger injured in traffic accident
- .9 Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident

V18 Pedal cyclist injured in noncollision transport accident

[\[See before V10 for subdivisions\]](#)

- Incl.:** fall or thrown from pedal cycle (without antecedent collision) overturning:
- NOS
 - without collision

Gambar 4.8 Kasus Sebab Luar

Sumber: Volume I ICD-10

Berdasarkan penjelasan diatas (gambar 4.7 dan 4.8), maka kode akhir pada kasus tersebut adalah S72.41, V18.04.

Kode pada Bab XIX (*Injury, poisoning and certain other consequences of external causes*) wajib mencantumkan kode Bab XX sebagai penyebab luarnya. Kode sebab luar (Bab XX) menunjukkan penyebab kejadian, lokasi kejadian dan aktivitas (WHO, 2010). Informasi tersebut diperlukan sebagai pertimbangan pasien layak mendapat jaminan BPJS kesehatan atau jaminan BPJS ketenagakerjaan atau Jasa Raharja.

Bilamana dua kode dapat digunakan untuk menggambarkan suatu cedera, keracunan atau efek samping lain: suatu kode dari Bab XIX, yang mendeskripsikan kondisi cedera, ditambah kode dari Bab XX, yang menunjukkan penyebabnya. Kode mana yang dipilih sebagai kode tambahan tentunya tergantung pada tujuan pengumpulan datanya (baca introduction Bab XX pada Volume 1 ICD-10).

4. Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Sesuai Dokumentasi Penunjang Klinis

Kode diagnosis merepresentasikan kondisi sakit pasien. Permasalahan dalam penentuan kode diagnosis adalah tidak semua kondisi medis pasien ditulis pada rekam medis dengan lengkap sehingga berdampak pada ketidaksesuaian kode.

Contoh:

Dokter menulis diagnosis Infeksi Saluran Kemih (ISK). Coder memberikan kode N39.0, namun hasil pengkodean tersebut di pending oleh BPJS.

Klarifikasi: klaim tersebut di pending karena pada anamnesis tidak tertulis nyeri BAK positif (+) dan tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium yang menjelaskan Kultur positif (+) (BA kesepakatan BPJS tahun 2018). Kesimpulan: kualitas dokumentasi rekam medis menjadi kunci keakuratan kode diagnosis.

5. Kegagalan Reseleksi Kode Diagnosis Utama

Reseleksi kode diagnosis utama menjadi langkah krusial dalam menjaga integritas kode diagnosis. Kode diagnosis utama merepresentasikan sumber daya terbesar dalam perawatan pasien. Kegagalan reSeleksi kode diagnosis utama akan berdampak pada hasil kode CMG pada INA CBG dan tentunya pada biaya klaim pasien.

Contoh:

Diagnosis utama : Hipertensi

Diagnosis sekunder : *Chronic Kidney Disease*

Tindakan : Hemodialisis

Coder memberikan kode ICD-10 : I10 (*Hypertension*) dan N18.9 (*Chronic Kidney Disease*).

Klarifikasi: Pada kasus tersebut coder cukup memberikan kode tunggal yaitu I12.0 (*Hypertensi renal disease with renal failure Hypertensi renal failure*). Perhatikan pada kategori I12 *includes* (gambar 4.9):

I12	Hypertensive renal disease
	Incl.: any condition in N00-N07, N18.-, N19 or N26 due to hypertension arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis
	Excl.: secondary hypertension (I15.-)
I12.0	Hypertensive renal disease with renal failure Hypertensive renal failure
I12.9	Hypertensive renal disease without renal failure Hypertensive renal disease NOS

Gambar 4.9 Kekhususan Kasus Hipertensi

Sumber: Volume I ICD-10

Pada aturan Rules for Morbidity dijelaskan bahwa diagnosis utama didefinisikan sebagai kondisi (diagnosis) yang bertanggungjawab atas kebutuhan pasien akan perawatan, pemeriksaan dan tindakan. Apabila ada >1 diagnose maka dipilih yang paling bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang terbesar (WHO, 2010).

Diagnosis utama merupakan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter pada akhir episode perawatan yang menyebabkan pasien mendapatkan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Jika terdapat lebih dari satu diagnosis, maka dipilih yang menggunakan sumber daya

paling banyak dengan tetap berpedoman pada aturan koding sesuai dengan Pedoman INA-CBG, kecuali dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut beserta penyelesaiannya akan disepakati bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

6. Kegagalan Reseleksi Kode Diagnosis Sekunder

Kode diagnosis sekunder merepresentasikan penyakit yang menyertai dan atau komplikasi dari diagnosis utama yang membutuhkan tata laksana pelayanan kesehatan. Kode diagnosis sekunder pada INA-CBG akan berpengaruh terhadap tingkat keparahan (*severity level*). Semakin tinggi *severity level* maka semakin besar biaya klaim. Kegagalan reSeleksi kode diagnosis sekunder berpotensi menyebabkan terjadinya *up coding* atau bahkan *down coding*. Oleh karena itu coder perlu memilih kembali (reSeleksi) kode diagnosis sekunder yang dibuktikan dengan tata laksana pelayanan kesehatan pada rekam medis pasien.

Contoh:

Diagnosis utama: Neoplasma ganas pada payudara kiri

Diagnosis sekunder: Efulsi pleura

Prosedur: -

Tidak ada informasi prosedur thorakosintesis maupun foto toraks/USG/CT Scan.

Coder memberikan kode ICD-10: C50.9 (*Malignant neoplasm of breast, unspecified*) sebagai kode diagnosis

utama dan J90 (*Pleural effusion, not elsewhere classified*) sebagai kode diagnosis sekunder.

Severity level: III. Hasil pengodean ditolak, klaim pending.

Klarifikasi: Pada kasus tersebut terjadi kegagalan reseleksi kode diagnosis sekunder karena coder memberikan kode J90 (*Pleural effusion, not elsewhere classified*) sebagai diagnosis sekunder sehingga meningkatkan *severity level*. Efusi pleura dapat dikode apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini (BPJS Kesehatan, 2023):

- a. Efusi pleura dengan jumlah berapapun dan penyebabnya apapun yang terbukti terdapat cairan dengan tindakan pungsi pleura/ thorakosintesis.
- b. Efusi pleura yang terbukti dengan pemeriksaan imaging (foto toraks dan/ atau USG toraks dan/ atau CT Scan toraks) dengan jumlah minimal atau lebih dari minimal yang disertai dengan tindakan punksi pleura (tidak harus keluar Cairan) dan /atau tatalaksana tambahan sesuai penyebabnya diluar tata laksana diagnosis primer.

Definisi efusi pleura dengan jumlah minimal bila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Gambaran efusi pada foto *toraks lateral decubitus* dan/atau CT Scan *toraks* dengan ketebalan kurang dari 10 mm.

- b. Gambaran efusi pada USG toraks dengan jumlah cairan kurang dari 100 ml dan/atau jarak antara pleura parietal dan pleura visceral kurang dari 10 mm (BA Kesepakatan Bersama Tahun 2018).

Diagnosis sekunder merupakan diagnosis yang menyertai diagnosis utama pada saat pasien masuk atau yang terjadi selama episode perawatan. Diagnosis sekunder merupakan komorbiditas dan/atau komplikasi. Komorbiditas adalah penyakit yang menyertai diagnosis utama atau kondisi yang sudah ada sebelum pasien masuk perawatan dan membutuhkan pelayanan kesehatan/tata laksana setelah masuk maupun selama perawatan. Sedangkan komplikasi adalah penyakit yang timbul dalam masa perawatan dan memerlukan pelayanan tambahan yang mendapatkan tatalaksana sewaktu episode pelayanan, baik yang disebabkan oleh kondisi yang ada atau muncul akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (BPJS Kesehatan, 2023).

7. Kegagalan Reseleksi Kode Prosedur Medis

Reseleksi kode prosedur medis menjadi bagian penting, karena koding prosedur medis bersifat multiple, artinya kode prosedur medis merepresentasikan semua prosedur diagnostik, terapeutik dan penunjang yang didapatkan pasien selama episode perawatan. Akan tetapi, coder perlu memilih kembali (reseleksi) prosedur

yang relevan dengan manajemen pelayanan kesehatan pasien. Contoh:

Diagnosis utama: *Acute appendicitis with peritoneal abscess*

Diagnosis sekunder : -

Prosedur: *Laparotomy, Appendectomy*

Coder memberikan kode ICD-10:

K35.8 (*Acute appendicitis with peritoneal abscess*)

sebagai diagnosis utama, dan kode ICD-9CM: 54.19 (*other laparotomy*) dan 47.09 (*Other appendectomy*).

Hasil pengodean ditolak, klaim pending.

Klarifikasi: Pada kasus tersebut terjadi kegagalan reseleksi kode prosedur medis karena coder memberikan kode 54.19 (*other laparotomy*) sehingga terjadi *up coding*. *Laparotomy* tidak perlu dikode, karena prosedur utama adalah *appendectomy*. Pada ICD-9CM kode 54.19 (*other laparotomy*) as *operative approach* -- *omit* code. Kata *omit code* menunjukkan arti tidak dikoding. Hal ini juga sesuai dengan BA kesepakatan tahun 2019, PMK 26 Tahun 2021 bahwa jika ada pernyataan *omit code* pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Kemenkes RI, 2021; BPJS Kesehatan, 2023).

Bab 5

Instrumen Pengukuran Kualitas Kode Klinis

A. Audit Kode Klinis

Tujuan utama pengkodean adalah untuk menyediakan representasi informasi yang akurat, konsisten, dan ringkas terkait dengan kondisi pasien dan layanan yang diberikan kepada pasien (Lowell E.S, 2004; AHIMA, 2007). Oleh karena itu, kualitas kode yang diberikan pada data klinis sangat penting di mana pun perawatan telah diberikan (Jordan.K et all, 2004). Berdasarkan perspektif tersebut kualitas kode kinis menghasilkan dan memelihara data berkualitas tinggi dapat dianggap sebagai bagian dari praktik rutin rangkaian layanan kesehatan (AHIMA, 2001), dan dapat membantu rangkaian layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk memastikan penggantian layanan kesehatan yang adil, dan untuk memungkinkan penelitian berkualitas tinggi dilakukan (Bajaj.Y et all, 2007).

Audit pengkodean klinis memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut di atas. Selain itu, melakukan audit kode klinis secara teratur dapat memberikan informasi berharga untuk program peningkatan kualitas berkelanjutan dan dapat mendukung Pembayaran berdasarkan. Penilaian kualitas kode dilakukan membandingkan apa yang didokumentasikan secara klinis dalam rekam medis dengan apa yang diberi kode (Department of the NAVY, 2010; NHS Digital, 2010). Program audit secara aktif memperkuat kemampuan fasilitas untuk menghasilkan set data pengkodean medis yang akurat dan lengkap dari rekam medis (Department of the NAVY, 2010).

Program audit kode klinis diperlukan dengan tujuan menyoroti area masalah dan menyediakan informasi dan alat yang diperlukan untuk memastikan dihasilkannya data berkualitas tinggi (Hudovsky A. and Wiek-Cohen M., 2008). Program audit kode klinis juga mendukung informasi statistik yang akurat, handal, dan lengkap tentang penggunaan layanan perawatan kesehatan dalam komunitas. Sebagian besar program bertujuan untuk meningkatkan kualitas kode dengan meningkatkan akurasi kode (AHIMA, 2008). Oleh karena itu, program audit kode klinis perlu direncanakan dengan baik dan diharapkan mencakup lebih banyak atribut kualitas dari pada terbatas pada atribut tertentu seperti akurasi kode.

Pada instrumen audit pengkodean klinis, terdapat tujuh elemen yang dinilai *reliability*, *completeness*, *timeliness*, *accuracy*, *definition*, *relevancy* dan *legibility* (Moghaddasi.H et all, 2014; Nasution and Hosizah, 2020; Hosizah *et al.*, 2024):

1. *Reliability*

Reliability merupakan konsistensi kode diagnosa dan tindakan yang dihasilkan oleh setiap *clinical coder*. Kualitas kode disebut reliabel apabila terdapat konsistensi kode diagnosis dan tindakan yang dihasilkan oleh setiap *clinical coder*, sedangkan tidak reliabel jika tidak terdapat konsistensi kode diagnosis dan tindakan yang dihasilkan oleh setiap *clinical coder*.

2. *Completeness*

Completeness merupakan kode diagnosa yang lengkap yaitu mencakup diagnosa primer, diagnosa sekunder (jika diperlukan) dan tindakan (jika ada). Kualitas kode disebut lengkap apabila terdapat kode diagnosa yang lengkap yang dihasilkan oleh setiap *clinical coder*.

3. *Timeliness*

Timeliness menunjukkan data harus tepat waktu dan terkini (Moghaddasi.H et all, 2014). *Timeliness* merupakan penetapan kode diagnosa dilakukan maksimal 1 x 24 jam setelah selesai diberikan pelayanan (Nasution and Hosizah, 2020). Kualitas kode disebut tepat waktu jika *clinical coder* menetapkan kode diagnosa 1 x 24 jam setelah pelayanan selesai diberikan, sedangkan disebut tidak tepat waktu jika *clinical coder* menetapkan kode

diagnosa lebih dari 1 x 24 jam setelah pelayanan selesai diberikan.

4. *Accuracy*

Accuracy merupakan kesesuaian diagnosis yang ditetapkan oleh dokter dan tindakan yang diberikan kepada pasien dengan kode diagnosa dan tindakan yang ditetapkan oleh *clinical coder* sesuai dengan ICD-10 dan ICD 9 CM. Kualitas kode disebut akurat jika kode diagnosa dan tindakan yang ditetapkan *clinical coder* sudah sesuai dengan ICD-10 dan ICD 9 CM.

5. *Definition*

Definition menunjukkan data harus valid, tepat, dapat dipahami dan memiliki makna yang jelas. Definisi merupakan pemahaman semua singkatan, istilah dan simbol yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

6. *Relevancy*

Relevancy merupakan kode diagnosa dan tindakan yang dihasilkan harus sesuai dan dapat digunakan untuk statistik pelaporan dan penggantian biaya. Kualitas kode dikatakan relevan jika kode diagnosa dan tindakan sudah tepat.

7. *Legibility*

Legibility dinilai dari diagnosa dan tindakan yang tertulisdalam lembaran resume medis dan lembaran lain yang diperlukan seperti catatan perkembangan pasien terintegrasi, patologi anatomi dan laporan operasi harus dapat dibaca dan mudah dipahami.

B. Instrumen Pengukuran Kualitas Kode Klinis Pada Sistem Casemix

Kualitas kode klinis merupakan tingkat keakuratan dan ketepatan kode diagnosis sesuai ICD-10 tahun 2010 dan prosedur medis sesuai ICD9-CM, Kualitas kode klinis pada sistem casemix menunjukkan tingkat keakuratan dan ketepatan kode diagnosis sesuai ICD-10 tahun 2010 dan prosedur medis sesuai ICD9-CM dengan memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan implementasi koding INA-CBG. Berdasarkan permasalahan kualitas kode klinis pada sistem casemix yang sudah di bahas pada Bab 4 Sub Bab B, maka untuk mengukur kualitas kode kode klinis pada sistem casemix diperlukan suatu instrumen. Berikut instrumen pengukuran kualitas kode klinis pada sistem casemix:

1. Keakuratan Kode Diagnosis Berdasarkan Prinsip Umum (*General Principle*)

Definisi : Keakuratan kode diagnosis berdasarkan prinsip umum (*general principle*) adalah pemberian kode diagnosis untuk setiap diagnosis, yang tidak termasuk pada kode kombinasi dan kode ganda.

Parameter : Parameter keakuratan kode diagnosis berdasarkan prinsip umum (*general principle*) meliputi Akurat, Tidak Akurat dan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

- Akurat, apabila kode diagnosis sesuai kaidah ICD-10.

- Tidak akurat, apabila kode diagnosis tidak sesuai kaidah ICD-10.
- Tidak Dapat Diterapkan (TDD), apabila kasus kode diagnosis menggunakan kode kombinasi dan kode ganda.

2. Keakuratan Kode Diagnosis Kombinasi Sesuai Kaidah ICD-10

Definisi : Kode diagnosis kombinasi adalah kode yang diberikan untuk mengklasifikasi beberapa diagnosis tetapi cukup dengan satu kode (kode tunggal). Keakuratan kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10 adalah keakuratan kode diagnosis, yang dapat diketahui dari *subterm* yang muncul dalam ICD-10, dengan merujuk pada *inclusion* ataupun *exclusion*.

Parameter : Parameter keakuratan kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10 meliputi Akurat, Tidak Akurat dan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

- Akurat, apabila kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10.
- Tidak akurat, apabila kode diagnosis kombinasi tidak sesuai kaidah ICD-10.
- Tidak Dapat Diterapkan (TDD), apabila:

(1) diagnosis tunggal; atau (2) terdapat beberapa diagnosis namun tidak dapat dikode menjadi satu kode (kode tunggal).

3. Keakuratan Kode Diagnosis Ganda Sesuai Kaidah ICD-10

Definisi : Kode ganda adalah kode diagnosis ICD-10 untuk beberapa diagnosis, yang tidak dapat menggunakan aturan kode kombinasi. Keakuratan kode diagnosis ganda sesuai kaidah ICD-10 adalah keakuratan kode ganda, yang dapat berupa kode Dagger (†) dan Asterisk (*), kode dengan catatan "*Use additional code, if desired*" maupun kode ganda (dua kode) lain pada ICD-10 yang mendeskripsikan kondisi seseorang secara utuh.

Parameter : Parameter keakuratan kode diagnosis ganda sesuai kaidah ICD-10 meliputi Akurat, Tidak Akurat dan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

- Akurat, apabila kode diagnosis ganda sesuai kaidah ICD-10.
- Tidak akurat, apabila kode diagnosis ganda tidak sesuai kaidah ICD-10.
- Tidak Dapat Diterapkan (TDD), apabila:

- (1) diagnosis tunggal; atau (2) terdapat beberapa diagnosis namun dapat dikode dengan aturan kode kombinasi.

4. Keakuratan Kode Diagnosis Sesuai Dokumentasi Penunjang Klinis

Definisi : Dokumentasi penunjang klinis adalah informasi vital untuk menegaskan diagnosis, seperti anamnesis, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan radiologi, hasil pemeriksaan lainnya yang relevan dengan kondisi pasien. Keakuratan kode diagnosis sesuai dokumentasi penunjang klinis adalah keakuratan kode diagnosis ICD-10 sesuai dengan dokumentasi penunjang klinis.

Parameter : Parameter keakuratan kode diagnosis sesuai dokumentasi penunjang klinis meliputi Akurat dan Tidak Akurat.

- Akurat apabila kode diagnosis sesuai dengan dokumentasi penunjang klinis.
- Tidak akurat, apabila kode diagnosis sesuai dengan dokumentasi penunjang klinis.

Tidak ada parameter Tidak Dapat Diterapkan (TDD) karena pada setiap diagnosis pasien pasti memiliki informasi

dokumentasi penunjang klinis pada rekam medis.

5. Ketepatan Reseleksi Kode Diagnosis Utama

Definisi : Ketepatan reseleksi kode diagnosis utama adalah ketepatan pemilihan (reseleksi) kode diagnosis yang merepresentasikan alasan pasien dirawat, menunjukkan sumber daya terbesar dan dibuktikan dengan tata laksana pelayanan kesehatan pada rekam medis.

Parameter : Parameter ketepatan reseleksi kode diagnosis utama meliputi Tepat, Tidak Tepat

- Tepat, apabila hasil reseleksi kode diagnosis utama sesuai dengan sumber daya terbesar pada tata laksana pelayanan kesehatan pasien.

- Tidak Tepat, apabila hasil reseleksi kode diagnosis utama tidak sesuai dengan sumber daya terbesar pada tata laksana pelayanan kesehatan pasien.

Tidak ada parameter Tidak Dapat Diterapkan (TDD) karena pada setiap pasien pasti memiliki diagnosis utama.

6. Ketepatan Reseleksi Kode Diagnosis Sekunder

Definisi : Ketepatan reSeleksi kode diagnosis sekunder adalah ketepatan pemilihan (reseleksi) kode diagnosis komorbid maupun komplikasi yang berpengaruh pada diagnosis utama dan dibuktikan dengan tata laksana pelayanan kesehatan pada rekam medis pasien.

Parameter : Parameter ketepatan reSeleksi kode diagnosis sekunder meliputi Tepat, Tidak Tepat dan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

- Tepat, apabila hasil reSeleksi kode diagnosis sekunder sesuai dengan sumber daya yang diberikan, yang berpengaruh pada tata laksana pelayanan kesehatan pasien.
- Tidak Tepat, apabila hasil reSeleksi kode diagnosis sekunder tidak sesuai dengan sumber daya yang diberikan, yang berpengaruh pada tata laksana pelayanan kesehatan pasien
- Tidak Dapat Diterapkan (TDD) apabila kasus diagnosis tunggal tanpa komorbid maupun komplikasi.

7. Ketepatan Reseleksi Kode Prosedur Medis

Definisi : Ketepatan reseleksi prosedur medis adalah ketepatan pemilihan (reseleksi) kode prosedur operasi dan non operasi yang telah diberikan pada pasien dan terdokumentasi pada rekam medis dengan memperhatikan ketentuan koding prosedur medis.

Parameter : Parameter ketepatan reseleksi prosedur medis meliputi Akurat, Tidak Akurat dan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

- Akurat, apabila hasil reseleksi kode prosedur medis sesuai ketentuan koding prosedur medis..
- Tidak akurat, apabila hasil reseleksi kode prosedur medis tidak sesuai ketentuan koding prosedur medis.
- Tidak Dapat Diterapkan (TDD), apabila pasien tidak dilakukan prosedur medis.

**Tabel 5.1 Formulir Pengukuran Kualitas Kode Klinis
Pada Implementasi Sistem Casemix**

Sampel	Diagnosis	Prosedur Medis	Informasi Penunjang Klinis	Kode ICD-10	Kode ICD-9CM	Rule	Spesialisasi DPIP	Keakuratan kode diagnosis berdasarkan prinsip umum (<i>General Principle</i>)*	Keakuratan kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10*	Keakuratan kode diagnosis ganda sesuai kaidah ICD-10*	Keakuratan kode diagnosis sesuai dokumentasi penunjang klinis	Ketepatan seleksi kode diagnosis utama	Ketepatan seleksi kode diagnosis sekunder	Ketepatan seleksi prosedur medis
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
...														
n														

Cara pengisian formulir pengukuran kualitas kode klinis pada sistem casemix:

Tanda * pada kolom (i), (j) dan (k) : pilihlah satu kolom saja diantara 3 kategori sesuai kasus pada rekam medis, meliputi kode diagnosis dengan prinsip umum maka dipilih (i), kode diagnosis kombinasi dipilih (j) dan kode diagnosis ganda dipilih (k). Apabila telah memilih salah satu maka untuk dua kolom lain diisi dengan Tidak Dapat Diterapkan (TDD).

Sampel: diisi dengan nomor sampel.

- (a) Diagnosis: diisi dengan diagnosis utama dan sekunder, baik diagnosis komorbid maupun komplikasi sesuai yang ditegakkan DPJP.
- (b) Prosedur Medis: diisi dengan prosedur medis baik operasi maupun non operasi yang diberikan kepada pasien.
- (c) Kode ICD-10 : diisi kode ICD-10 dari hasil pengodean diagnosis utama dan sekunder.
- (d) Kode ICD-9CM: diisi kode ICD-9CM dari hasil pengodean prosedur medis baik operasi maupun non operasi
- (e) *Rule*: diisi sesuai rule/aturan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan reseleksi diagnosis utama, dengan memilih rule *General Principle*, MB 1, MB 2, MB 3, MB 4 atau MB 5.
- (f) Spesialisasi DPJP: diisi sesuai spesialisasi dari DPJP

- (g) Keakuratan kode diagnosis berdasarkan prinsip umum (*General Principle*): diisi Akurat atau Tidak akurat atau TDD
- (h) Keakuratan kode diagnosis kombinasi sesuai kaidah ICD-10: diisi Akurat atau Tidak akurat atau TDD
- (i) Keakuratan kode diagnosis ganda sesuai kaidah ICD-10: diisi Akurat atau Tidak akurat atau TDD
- (j) Keakuratan kode diagnosis sesuai dokumentasi penunjang klinis: diisi Akurat atau Tidak akurat
- (k) Ketepatan reseleksi kode diagnosis utama: diisi Tepat atau Tidak Tepat
- (l) Ketepatan reseleksi kode diagnosis sekunder: diisi Tepat atau Tidak Tepat atau TDD
- (m) Ketepatan reseleksi prosedur medis: diisi Tepat atau Tidak Tepat atau TDD

Bab 6

Penutup

Kode klinis adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengklasifikasikan diagnosis dan prosedur medis. Klasifikasi diagnosis menggunakan ICD-10, sedangkan klasifikasi prosedur medis menggunakan ICD-9CM.

Casemix (*case based payment*) merupakan sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan software grouper yang saat ini dikenal dengan *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG). Dasar pengelompokkan, INA-CBG menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan prosedur medis yang menjadi bukti tata laksana pelayanan dan terdokumentasi pada rekam medis. Klasifikasi kode diagnosis menggunakan ICD-10 Versi tahun 2010 dan untuk kode prosedur medis menggunakan ICD-9CM.

Kualitas kode klinis merupakan tingkat keakuratan dan ketepatan kode diagnosis sesuai ICD-10 tahun 2010 dan prosedur medis sesuai ICD9-CM, Kualitas kode klinis pada sistem casemix menunjukkan tingkat keakuratan dan

ketepatan kode diagnosis sesuai ICD-10 tahun 2010 dan prosedur medis sesuai ICD9-CM dengan memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan implementasi koding INA-CBG.

Melalui buku ini, kami telah menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas rekam medis, karena informasi dokumentasi penunjang klinis pada rekam medis akan digunakan sebagai dasar penentuan kode diagnosis dan informasi dokumentasi prosedur medis akan digunakan sebagai dasar penentuan kode prosedur medis. Pemanfaatan kode ICD-10 dan ICD-9CM menjadi komponen kunci dalam penentuan biaya pada implementasi sistem casemix di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kode ICD-10 dan ICD-9CM akan menentukan hasil kode CMG sebagai representasi tata laksana pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien dan menentukan besar biaya klaim.

Tugas dan tanggung jawab seorang koder yaitu melakukan kodifikasi diagnosis dan prosedur medis yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 versi 2010 untuk diagnosis dan ICD-9CM untuk prosedur medis bersumber dari rekam medis. Apabila dalam melakukan pengodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder menemukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umum pengodean, maka

koder harus melakukan klarifikasi dengan dokter.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Perekam Medis, khususnya Koder, Dokter, Pihak manajemen RS, BPJS kesehatan, Peneliti, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga kualitas kode klinis pada sistem casemix. Untuk memperkuat dampak pemberdayaan ini, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret dalam melakukan pengodean untuk menjaga kualitas kode klinis yang dapat dilakukan:

1. Pastikan kesesuaian diagnosis dan prosedur medis yang ditegakkan dokter yang merawat pasien dengan dokumentasi penunjang klinis dan bukti penatalaksanaan kesehatan pasien pada rekam medis.
2. Hasil reseleksi pada langkah ke-1 akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kode diagnosis dan prosedur medis:
 - a. Reseleksi diagnosis utama yang perlu dikode
 - b. Reseleksi diagnosis sekunder yang perlu dikode
 - c. Reseleksi prosedur medis yang perlu dikode
3. Pada saat menentukan kode diagnosis perhatikan aturan prinsip umum (*general principle*), aturan kode kombinasi dan kode ganda sesuai ICD-10 versi tahun 2010 dan regulasi terkait INA-CBG.
4. Pada saat menentukan kode prosedur medis perhatikan aturan sesuai ICD-9CM versi tahun 2010 dan regulasi terkait INA-CBG.

Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa instrument kualitas kode klinis pada sistem casemix diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan koder dalam memahami outcome kualitas kode klinis. Melalui buku ini, penulis juga menegaskan bahwa rekam medis yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas kode klinis. Dengan semangat kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran antara koder dengan dokter dan para pemberi asuhan pelayanan kesehatan, mari kita wujudkan dokumentasi rekam medis yang berkualitas untuk mendukung peningkatan kualitas kode klinis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata.

Daftar Pustaka

- AHIMA (2001) 'The Coding Policy and Strategy Committee. Payer's Guide to Healthcare Diagnostic and Procedural Data Quality.', *Journal of AHIMA*.
- AHIMA (2007) *Statement on Consistency of Healthcare Diagnostic and Procedural Coding*.
- AHIMA (2008) 'e-HIM Work Group on Benchmark Standards for Clinical Coding Performance Measurement quality subgroup. "Collecting Root Cause to Improve Coding Quality Measurement."', *Journal of AHIMA*, 79(3), pp. 71–75.
- Amir.B.I etall (2020) 'Identifikasi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.', *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)*, 1(2).
- Ariyanti, F. and Gifari, M. T. (2019) 'Analisis Persetujuan Klaim BPJS Kesehatan pada Pasien Rawat Inap', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(04), pp. 156–166. doi: 10.33221/jikm.v8i04.415.
- Bajaj.Y et all (2007) 'Clinical coding: how accurately is it done?', *British Journal of Clinical Governance*, 12(3), pp. 156–169.
- BPJS Kesehatan (2015) *Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- BPJS Kesehatan (2016) *Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Dispute Klaim Dalam Penyelenggaraan JKN*.
- BPJS Kesehatan (2018) *Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan*.

- BPJS Kesehatan (2023) *Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2023 No JP.02.03/H.IV/1627/2023, No 415/Ba/0623*. Jakarta.
- Campbell, Susan E., Campbell, Marion K., Grimshaw, Jeremy M., & Walker, A. E. (2001) 'A systematic review of discharge coding accuracy', *Journal of Public Health*, 23(3), pp. 205-211.
- Delvaux, N. *et al.* (2020) 'Coding Systems For Clinical Decision Support: Theoretical and Real-World Comparative Analysis', *JMIR Formative Research*, 4(10). doi: 10.2196/16094.
- Department of the NAVY (2010) *Coding program standard audit*. USA. Available at: www.med.navy.mil.
- Dimick, C. (2010) 'Achieving Coding Consistency', *Journal of AHIMA*, 81(7).
- Hosizah *et al.* (2024) 'Audit Kode Klinis Pasien Rawat Inap Jaminanan BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tipe C Dan D Wilayah DIY', *Jurnal Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (JPIKI)*, 9(2), pp. 189–199.
- Hudovsky A. and Wiek-Cohen M. (2008) *Implementation of Hospital Clinical Coding Audits in the Czech Republic*. UK. Available at: www.mzcr.cz.
- Indawati, L. (2019) 'Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), p. 113. doi: 10.33560/jmiki.v7i2.230.
- Jordan.K et all (2004) 'Quality of morbidity coding in general practice computerized medical records: a systematic review', *Fam Pract*, 21(4), pp. 396–412. doi: 10.1093/fampra/cmh409.
- Kemenkes (2016) *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*.

- Kemenkes RI (2021) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)*. Available at: <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/09/PMK-262021.pdf>.
- Kodyat.A.G etall (2020) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pending Klaim Rawat Inap Oleh BPJS Di RSAB Harapan Kita Jakarta Barat Tahun 2019', *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(2), pp. 191–197. Available at: <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI/article/view/1040>.
- Krawczyk, P. and Swiecicki, L. (2020) 'ICD-11 vs. ICD-10 - A review of updates and novelties introduced in the latest version of the WHO International Classification of Diseases', *Psychiatria Polska*, 54(1), pp. 7–20. doi: 10.12740/PP/103876.
- Lowell E.S (2004) *Guidelines for Conducting Birth Defects Surveillance*. USA.
- Maesaroh, L., Sudra, R. I. and Arief, M. (2011) 'Analisis Kelengkapan Kode Klasifikasi Dan Kode Morphology Pada Diagnosis Carcinoma Mammae Berdasarkan ICD-10 Di RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun 2011', *Jurnal Kesehatan*, 5(2), p. 2. Available at: <https://ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/rm/article/viewFile/60/54>.
- Moghaddasi.H et all (2014) 'Improving The Quality Of Clinical Coding: A Comprehensive Audit Model', *Journal of Health Management & Informatics*, 1(2), pp. 36–40.
- Nasution, K. S. and Hosizah, H. (2020) 'Perancangan Instrumen Audit Pengkodean Klinis di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), p. 30. doi: 10.33560/jmiki.v8i1.255.
- NHS Digital (2010) *Connecting for Health. HS Classifications Service. A Guide to the Clinical Coding Audit Methodology*. Available

at: www.connectingforhealth.nhs.uk.

- Ningtyas, N. K., Sugiarsi, S. and Wariyanti, A. S. (2019) 'Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Utama Kasus Persalinan Sebelum dan Sesudah Verifikasi pada Pasien BPJS di Rsup Dr . Soeradji Tirtonegoro Klaten', *JKESVO*, 4(1), pp. 1–11.
- O'Malley, Kimberly J., Cook, Karon F., Price, Matt D., Wildes, Kimberly Raiford, Hurdle, John F., & Ashton, C. M. (2005) 'Measuring Diagnoses: ICD Code Accuracy', *Health Services Research*, 40(5), pp. 1620-1639.
- Oktamianiza etall (2021) 'Literatur Riview Tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tahun 2020', *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 6(1), pp. 83–90.
- Pratama.A. etall (2023) 'Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Inap Akibat Koding Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen', *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 8(1), pp. 123–134. Available at: <https://doi.org/10.52943/jipiki.v8i1.1225>.
- Presiden RI (2013) *Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*.
- Pujiastuti et al (2014) 'Hubungan Kelengkapan Informasi Dengan Keakuratan Kode Diagnosis dan Tindakan Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), pp. 60–64.
- Putu Anda Tusta Adiputra (2016) *Upaya Pengelolaan Registrasi Kanker di Rumah Sakit, Tim Registrasi Kanker RSUP Sanglah*. Bali: RSUP Sanglah.
- Seruni, F. D. A. and Sugiarsi, S. (2015) 'Problem Solving Cycle SWOT Keakuratan Kode Diagnosis Kasus Obstetri pada Lembar Masuk dan Keluar (RM 1A) Pasien Rawat Inap di RSUD Dr.

- Sayidiman Magetan', *Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), pp. 5–13.
- Ulfa, H. M., Octaria, H. and Sari, T. P. (2016) 'Analisis Ketepatan Kode Diagnosa Penyakit Antara Rumah Sakit Dan Bpjs Menggunakan Icd-10 Untuk Penagihan Klaim Di Rumah Sakit Kelas C Sekota Pekanbaru Tahun 2016', *Jurnal INOHIM*, 5(2), pp. 119–124.
- WHO (2010) *Revision, The Tenth Classification, International Statistical Problems, Related Health Classification*.
- Widjaja et al (2014) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keakurasian Koding Ibu Melahirkan Dan Bayi Di Beberapa Rumah Sakit Tahun 2014', *Jurna INOHIM*, 2(2), pp. 114–122.
- Windari, A. and Kristijono, A. (2016) 'Analisis Ketepatan Koding Yang Dihasilkan Koder Di RSUD Ungaran', *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), pp. 35–39. Available at: <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk>.
- Yuniati, D. I. (2017) 'Analisis Hasil Koding yang Dihasilkan oleh Coder di Rumah Sakit Pemerintah X di Kota Semarang Tahun 2012', *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 1(4), pp. 167–174. doi: 10.7454/eki.v1i4.1791.
- Zafirah, S. A. et al. (2018) 'Potential Loss Of Revenue Due To Errors In Clinical Coding During The Implementation Of The Malaysia Diagnosis Related Group (MY-DRG) Casemix System In A Teaching Hospital In Malaysia', *BMC Health Services Research*, 10(1).

Glosarium

B

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

C

Casemix (*Case based payment*) adalah sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan software grouper yang saat ini dikenal dengan *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG).

CMG (*Casemix Main Groups*) adalah klasifikasi tahap pertama yang dilabelkan dengan huruf Alphabet (A sampai Z) yang disesuaikan dengan ICD-10 Versi Tahun 2010 untuk setiap sistem organ tubuh manusia

G

GP (*General Principle*) adalah prinsip umum pengodean diagnosis.

I

ICD-10 (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision*) adalah sistem pengkodean internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit dan masalah terkait kesehatan.

ICD-9CM (*International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification*) adalah sistem pengkodean

internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan prosedur medis baik operasi maupun non operasi.

INA-CBG (*Indonesian Case-Based Groups*) adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan jenis penyakit, prosedur medis, dan biaya perawatan yang terkait, yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan biaya kesehatan.

J

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.. JKN diluncurkan pada tahun 2014 dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

K

Kode klinis adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengklasifikasikan diagnosis dan , prosedur medis. Klasifikasi diagnosis menggunakan ICD-10, sedangkan klasifikasi prosedur medis menggunakan ICD-9CM.

Kode diagnosis adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit dan masalah terkait kesehatan menggunakan ICD-10 versi tahun 2010.

Kode prosedur medis adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengklasifikasikan prosedur medis menggunakan ICD-9CM.

Koder adalah tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) yang bertugas melakukan pengodean klinis.

Reseleksi adalah proses pemilihan ulang atau peninjauan kembali kode diagnosis atau prosedur medis bersumber pada informasi rekam medis.

S

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) adalah sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

U

UHC (*Universal Health Coverage*) adalah program cakupan kesehatan semesta, yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dengan tujuan mencapai cakupan kesehatan yang universal, yaitu cakupan kesehatan yang mencakup semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis

W

WHO (*World Health Organization*) adalah organisasi kesehatan internasional yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi kesenjangan kesehatan di seluruh dunia.

Profil Penulis



Kori Puspita Ningsih, AMd., SKM., MKM., FISQua Lahir di Boyolali, 09 Januari 1988.

Penulis adalah putri pertama dari Bp. Much Ridwan dan Ibu Marganingsih, Bsc. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Rekam Medis Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada tahun 2008, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023, dan S2 Kesehatan Masyarakat

Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Universitas Diponegoro tahun 2019. Penulis juga mengikuti fellowship *International Society For Quality In Health Care* (FISQua) tahun 2025. Penulis mengawali karir sebagai praktisi di RS Mata Dr."Yap" pada tahun 2008-2015. Sejak tahun 2009 mulai mengajar di beberapa institusi pendidikan di wilayah Yogyakarta, dan pada tahun 2015 penulis menjadi dosen tetap di Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D-3) Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Saat ini penulis masih aktif sebagai Praktisi Perekam Medis di klinik swasta wilayah Yogyakarta. Penulis saat ini juga mengabdikan sebagai Kolegium Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK), Surveyor akreditasi FKTP (Puskesmas, Klinik, TPMD, TPMDG), Pengurus Pusat Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia (LAMFI), pengurus APTIRMIKI dan pengurus DPD PORMIKI DIY. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret.

Email Penulis : puspitakori@gmail.com

Profil Penulis



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

Penulis menempuh pendidikan S1 Kedokteran, Universitas Sebelas Maret (1990), Profesi Kedokteran Umum, Universitas Sebelas Maret (1992), S2 Ilmu Lingkungan, Universitas Sebelas Maret (2002) dan S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Universitas

Gadjah Mada (2010). Penulis pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNS periode 2015-2019 kemudian menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit UNS Periode 2020-2023.

Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor UNS Periode 2024-2029.

Email Penulis: hartono65@staff.uns.ac.id



Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD

Penulis alah dosen di Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret (UNS). Dr. Hafidha menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter di UNS berturut-turut tahun 1999 dan 2002, pendidikan graduate diploma dan master dalam bidang Epidemiologi Klinik dengan spesialisasi

Farmakoepidemiologi di Centre of Clinical Epidemiology and Biostatistics, University of Newcastle, Australia tahun 2007 dan 2008, serta pendidikan doktoral dalam bidang Epidemiologi Klinik dan Informatika Kesehatan di Institute of Health Informatics, University College London (UCL), Inggris tahun 2020.

Email Penulis : hafidha@staff.uns.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya kualitas kode klinis pada sistem casemix. Kode ICD-10 dan ICD-9CM menjadi komponen kunci dalam penentuan biaya pada implementasi sistem casemix di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kode ICD-10 dan ICD-9CM akan menentukan hasil kode CMG sebagai representasi tata laksana pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien dan menentukan besar biaya klaim. Koder melakukan kode diagnosis ICD-10 dan kode prosedur ICD-9CM bersumber pada informasi pada dokumentasi rekam medis. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar sistem casemix, kode diagnosis dan prosedur medis, permasalahan kualitas kode klinis dan instrumen pengukuran kualitas kode klinis.

Dalam konteks pemberdayaan, buku ini menekankan bahwa kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran antara koder dengan dokter dan para pemberi asuhan pelayanan kesehatan terhadap mutu dokumentasi rekam medis mampu untuk mendukung peningkatan kualitas kode klinis. Instrumen kualitas kode klinis pada sistem casemix diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan koder dalam memahami outcome kualitas kode klinis. Melalui buku ini, penulis juga menegaskan bahwa rekam medis yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas kode .

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, bagi Perekam Medis, khususnya Koder, Dokter, Pihak manajemen RS, BPJS kesehatan, Peneliti, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga kualitas kode klinis pada sistem casemix.

Buku ini membahas tentang pentingnya kualitas kode klinis pada sistem casemix. Kode ICD-10 dan ICD-9CM menjadi komponen kunci dalam penentuan biaya pada implementasi sistem casemix di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kode ICD-10 dan ICD-9CM akan menentukan hasil kode CMG sebagai representasi tata laksana pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien dan menentukan besar biaya klaim. Koder melakukan kode diagnosis ICD-10 dan kode prosedur ICD-9CM bersumber pada informasi pada dokumentasi rekam medis. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar sistem casemix, kode diagnosis dan prosedur medis, permasalahan kualitas kode klinis dan instrumen pengukuran kualitas kode klinis.

Dalam konteks pemberdayaan, buku ini menekankan bahwa kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran antara koder dengan dokter dan para pemberi asuhan pelayanan kesehatan terhadap mutu dokumentasi rekam medis mampu untuk mendukung peningkatan kualitas kode klinis. Instrumen kualitas kode klinis pada sistem casemix diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan koder dalam memahami outcome kualitas kode klinis. Melalui buku ini, penulis juga menegaskan bahwa rekam medis yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas kode.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, bagi Perkam Medis, khususnya Koder, Dokter, Pihak manajemen RS, BPJS kesehatan, Peneliti, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga kualitas kode klinis pada sistem casemix.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7219-15-2



9

786347

219152

